



**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ**



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ»**

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ
«Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά ομαλού λειχήνα»

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΡΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Καθηγήτρια ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής
Καθηγήτρια ΖΩΗ ΑΠΑΛΛΑ
Καθηγητής ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΑΛΛΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

Με ατομική μου ευθύνη, δηλώνω υπεύθυνα ότι η συγγραφή αυτής της διπλωματικής είναι προϊόν αποκλειστικά προσωπικής μου εργασίας, δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής και γενικότερα δεν παραβιάζονται οι διατάξεις περί διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεν χρησιμοποιήθηκαν πηγές πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις βιβλιογραφικές αναφορές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ABSTRACT

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1 Η ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

2.2 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

2.3 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

2.4 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

2.5 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΥ ΟΜΑΛΟΥ
ΛΕΙΧΗΝΑ

2.6 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΤΡΟΦΙΚΟΥ) ΟΜΑΛΟΥ
ΛΕΙΧΗΝΑ

2.7 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

2.8 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΛΑΜΟΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

2.9 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΜΦΙΓΟΕΙΔΟΥΣ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

2.10 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

2.11 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ
ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ

2.12 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ
ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ

2.13 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΥΛΑΚΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

2.14 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ ΟΝΥΧΟΣ

3. ΜΕΘΟΔΟΣ

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δερματοσκόπηση είναι μια μη επεμβατική εξέταση, που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση φλεγμονωδών δερματοπαθειών, όπως ο ομαλός λειχήνας. Ο ομαλός λειχήνας είναι μια συχνή φλεγμονώδης δερματοπάθεια με χαρακτηριστικά δερματοσκοπικά ευρήματα. Το πιο συχνό δερματοσκοπικό εύρημα του ομαλού λειχήνα είναι το δίκτυο Wickham (Wickham Striae), το οποίο θεωρείται παθογνωμονικό για τον ομαλό λειχήνα, ωστόσο η απουσία αυτού δεν αποκλείει τη διάγνωση. Η διάγνωση του ομαλού λειχήνα πολλές φορές τίθεται κλινικά, αλλά σε περιπτώσεις με άτυπη κλινική εικόνα η διαγνωστική εξέταση εκλογής είναι η βιοψία. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση ιστολογικά επιβεβαιωμένων κλινικών περιστατικών ομαλού λειχήνα, με τις κλινικές και τις αντίστοιχες δερματοσκοπικές εικόνες αυτών και την περιγραφή των δερματοσκοπικών ευρημάτων σε αντιστοιχία με τα παθολογοανατομικά ευρήματα. Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η αναζήτηση νέων δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών του ομαλού λειχήνα καθώς επίσης να αναδειχθεί ο ρόλος της δερματοσκόπησης τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση των ασθενών με ομαλό λειχήνα .

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δερματοσκόπηση, Ομαλός Λειχήνας, δίκτυο του Wickham.

ABSTRACT

Dermoscopy is a non-invasive technique, which is used for the evaluation of inflammatory dermatopathies, such as lichen planus. Lichen planus is a common inflammatory dermatopathy with unique dermoscopic findings. The most common dermoscopic finding is Wickham Striae, which is considered pathognomonic of lichen planus, although its absence can not exclude the diagnosis.

Lichen planus diagnosis is clinically established in many cases, although in atypical clinical signs, biopsy is necessary. The current research deals with the presentation of histologically confirmed cases of lichen planus, taking into account the clinical as well as the dermoscopic findings in correspondence with the histological findings. Our study sets as its main purpose to assess new dermoscopic findings in lichen planus, but also to enlighten the role of dermoscopy in the diagnosis and follow up of lichen planus patients.

KEY WORDS: Dermoscopy, Lichen planus, Wickham Striae.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

α/α	ατομικό αναμνηστικό
ΔΟΛ	Δακτυλιοειδής Ομαλός Λειχήνας
ΜΑΟΛ	Μελαγχρωματικός – Ανάστροφος Ομαλός Λειχήνας
ΜΟΛ	Μελαγχρωματικός Ομαλός Λειχήνας
ΟΛ	Ομαλός Λειχήνας
ΠΑΓΝΗ	Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
ΠΠΟΛ	Παλαμοπελματιαίος Ομαλός Λειχήνας
HCV	Ηπατίτιδα C
HLA	Human Leukocyte Antigen
IL	Interleukin
LP	Lichen Planus
PUVA	Psoralen plus ultraviolet A
Py	pack-year
SCC	Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
SWS	Shiny White Structures
TNF	Tumor necrosis factor
TNFαR	Tumor necrosis factor-alpha Receptor
WS	Wickham Striae

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΙΚΟΝΑ 1	σελ. 28
ΕΙΚΟΝΑ 2	σελ. 30
ΕΙΚΟΝΑ 3	σελ. 31
ΕΙΚΟΝΑ 4	σελ. 36
ΕΙΚΟΝΑ 5	σελ. 37
ΕΙΚΟΝΑ 6	σελ. 38
ΕΙΚΟΝΑ 7	σελ. 40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κλινικές μορφές ομαλού λειχήνα (10)	σελ. 10
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Δερματοσκοπικά πρότυπα του WS (40)	σελ. 14
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Δερματοσκοπικά ευρήματα ΟΛ με πολωμένο και μη πολωμένο (44)	σελ. 14
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Δερματοσκοπικά και Ιστοπαθολογικά ευρήματα μελέτης (53) σ 17	
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Δερματοσκοπικά πρότυπα μελαγχρωματικού ανάστροφου ΟΛ (40)	σελ. 17
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Δερματοσκοπικά και Ιστολογικά ευρήματα Ακτινικού ΟΛ (63)	σελ. 19
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Δερματοσκοπικά ευρήματα θυλακικού ΟΛ (40)	σελ. 23
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά ΜΟΛ σε πρόσθια ινωτική αλωπεκία (91)	σελ. 24
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Δερματοσκοπικά ευρήματα Ομαλού λειχήνα όνυχος (40)	σελ. 25
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών της μελέτης	σελ. 42
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Φύλο και μορφές ΟΛ με ποσοστά ασθενών της μελέτης	σελ. 42
ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά ασθενών της μελέτης Ιστοπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά ασθενών της μελέτης	σελ. 43
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Ιστολογικά ευρήματα στους ασθενείς της μελέτης	σελ. 44

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όρος “Lichen Planus” ή «Ομαλός Λειχήνας» περιγράφηκε πρώτη φορά το 1869 από τον Wilson Erasmus (1). Ο όρος αυτός προέρχεται από την λατινική λέξη “Planus” ή την αντίστοιχη ελληνική «ομαλός», που σημαίνει επίπεδος, λείος και από την αρχαία ελληνική λέξη «λειχήν», που είναι είδος αναρριχητικού φυτού. Ο ομαλός λειχήνας (ΟΛ) αποτελεί ένα χρόνιο αυτοφλεγμονώδες νόσημα, το οποίο προσβάλλει λίγο συχνότερα τις γυναίκες και αφορά όλες τις ηλικίες (συνήθως ενήλικες 30-60 ετών). Πιο συγκεκριμένα ο ΟΛ προσβάλλει 0,1% - 4% του γενικού πληθυσμού και είναι πιο συχνό στις μεσήλικες γυναίκες (2) .

Η αιτιοπαθογένεια παραμένει άγνωστη, ωστόσο θεωρείται αυτοάνοση αντίδραση επαγόμενη από T-λεμφοκύτταρα έναντι κερατινοκυττάρων μετά από κάκωση ή λοίμωξη (3). Η λειχηνοειδής διάμεση δερματίτιδα, που παρατηρείται στον ΟΛ, οφείλεται σε κυτταροτοξικά CD8+ που συγκεντρώνονται στο δέρμα. Έχουν συσχετιστεί πολλά διάφορα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας (HLA) με τον ΟΛ, όπως HLA-B27, HLA-B51, HLA-Bw57(oral), HLA-DR9, HLA-DRB1*11, HLA-DQB1*03, καθώς επίσης και οι γονιδιακοί σημειακοί πολυμορφισμοί (SNP) στο γονίδιο NRP-2 και IGFBP4. Πρόσφατες έρευνες συνδέουν την εμφάνιση του ομαλού λειχήνα με σημειακούς πολυμορφισμούς τριών γονιδίων: TSBP-1, HCG23 & BTNL2. Επίσης υπάρχουν συσχετισμοί με γονίδια που κωδικοποιούν για την μεταγραφή των κυτταροκινών TNF, TNFaR, IL-4, IL-6, IL-18. Ως αιτιολογικοί παράγοντες έχουν χαρακτηριστεί διάφορα περιβαλλοντικά αντιγόνα, όπως ιοί, φάρμακα και αλλεργιογόνα (3,4). Ο ΟΛ έχει συσχετιστεί με λοίμωξη από HCV(5). Πιθανολογείται ότι κάποιο προϊόν του ιού αναγνωρίζεται ως πιθανό αντιγόνο για τη δημιουργία της νόσου. Επίσης συχνά συνυπάρχει με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως γυροειδή αλωπεκία, ελκώδη κολίτιδα, ψωρίαση, κ.α.

Η κλινική εικόνα του ΟΛ παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια ανάλογα την περιοχή που προσβάλλει. Κλινικά παρουσιάζεται ως χρόνια κνησμώδης δερματοπάθεια που μπορεί να προσβάλλει το δέρμα, τους βλεννογόνους, το τριχωτό και τα νύχια. Οι βλάβες του ΟΛ εμφανίζονται συνήθως στις καμπτικές επιφάνειες των άκρων και έχουν χαρακτηριστική κλινική εικόνα. Συνήθως πρόκειται για κνησμώδεις (Pruritic) βλατίδες μεγέθους 1-10mm που συρρέουν

σε πλάκες (Papules and plaques), ερυθρο-ιώδεις (Purple), επίπεδες (Planar), στίλβουσες (Polished), πολυγωνικές (Polyangular), από όπου προκύπτει και ο μνημονικός κανόνας “6P” για την κλινική περιγραφή του ΟΛ (6,7). Χαρακτηριστικό επίσης είναι το λευκό δίκτυο του Wickham πάνω στις βλάβες, το οποίο είναι παθογνωμονικό της νόσου, ανευρίσκεται και δερματοσκοπικά, ενώ δεν είναι πάντα ορατό με γυμνό οφθαλμό. Οι βλάβες του ομαλού λειχήνα συνήθως παρουσιάζουν συμμετρική κατανομή και συχνά παρατηρείται το φαινόμενο του Koebner, δηλαδή εμφάνιση νέων βλαβών σε υγιές δέρμα μετά από ξεσμό ή τραυματισμό, το οποίο όμως δεν είναι παθογνωμονικό της νόσου. Ο ΟΛ έχει πολλές κλινικές μορφές εκτός από τον κλασσικό, όπως ακτινικός, πεμφιγοειδής, υπερτροφικός, ατροφικός, γραμμικός, δακτυλιοειδής, ανάστροφος, μελαγχωματικός, θυλακικός και άλλες (πίνακας 1) (6,8,9,10).

Πίνακας1. Κλινικές μορφές ομαλού λειχήνα (11)

Table 1. Clinical variants of cutaneous lichen planus.

Clinical variants
Classic LP
Hypertrophic LP
Annular LP
Bullous LP
Erythrodermic LP
LP pemphigoides
Lichen planus-lupus erythematosus overlap syndrome
LP actinicus
LP pigmentosus
LP pigmentosus-inversus
Atrophic LP
Follicular LP (Lichen planopilaris)
LP follicularis decalvans
Regressive lichen planus
Acute generalized lichen planus
Ulcerative LP
Linear LP
Nail LP
Oral LP
Genital LP
Esophageal LP
Otic LP

LP = lichen planus.

Agata Szykut-Badaczewska et al (11)

Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από λεμφοκυτταρική διήθηση στο δερμοεπιδερμидικό όριο με απόπτωση των κερατινοκυττάρων (κολλοειδή σωμάτια ή σωμάτια του Civatte), υπερκόκκωση, οδοντωτή διαμόρφωση της βασικής στιβάδας και μελανινοφάγα στο χόριο. Στη δερμοεπιδερμидική συμβολή παρατηρείται ταινιοειδής καθήλωση C3, IgM και περιστασιακά IgG και IgA με τον άμεσο ανοσοφθορισμό, που ονομάζονται κολλοειδή σωματίδια (12).

Πρόκειται για μια αυτοπεριοριζόμενη νόσο, με μέση διάρκεια 1-2 έτη. Συνήθως σε πάνω από το 50% των ασθενών η νόσος αυτοπεριορίζεται εντός 6 μηνών από την εμφάνιση και στο 85% εντός 18 μηνών (13,14).

Θεραπεία πρώτης γραμμής αποτελούν τα τοπικά κορτικοστεροειδή, αν και οι βλεννογονικές βλάβες και οι υπερτροφικές βλάβες ομαλού λειχήνα παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στη θεραπεία και μπορεί να διαρκέσουν δεκαετίες (15,16,17). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν και συστηματικά κορτικοστεροειδή ή άλλες συστηματικές θεραπείες με αντισταμινικά, κυκλοσπορίνη, ασιτρετίνη, PUVA, αζαθειοπρίνη, μεθοτρεξάτη, μυκοφαινόλη, ανθελνοσυστικά (18). Ενώ ο φαρμακοεπαγόμενος ΟΛ υποχωρεί συνήθως μετά από τη διακοπή του υπαίτιου φαρμάκου.

Η διάγνωση είναι κυρίως κλινική και δερματοσκοπική, ενώ η ιστολογική εξέταση επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Συνήθως δεν απαιτείται κάποια διαγνωστική εξέταση ή εξειδικευμένος εργαστηριακός έλεγχος, ωστόσο θα πρέπει να γίνεται ορολογικός έλεγχος για HCV, με την οποία έχει αποδειχτεί ότι σχετίζεται ο ΟΛ. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο άμεσος ανοσοφθορισμός μπορεί να συμβάλει στη διάγνωση (8,19). Ο ΟΛ θεωρείται δυνητικά προκαρκινική κατάσταση, καθώς το 1% των ασθενών με ΟΛ θα αναπτύξουν ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (SCC) επί βλαβών υπερτροφικού τύπου σε γεννητικά όργανα, πρωκτό, οισοφάγο και δέρμα (20,21). Συνεπώς μια βιοψία μπορεί να κριθεί απαραίτητη σε άτυπες κλινικές εικόνες (6,22,23) ή σε επίμονες βλάβες για τον αποκλεισμό SCC ή πρώιμης δυσπλασίας.

2 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

2.1 Η ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Η δερματοσκόπηση είναι μια μη επεμβατική μέθοδος, η οποία αποτελεί τμήμα της κλινικής εξέτασης. Με τη δερματοσκόπηση μπορούμε να δούμε δομές στην επιδερμίδα, δερμοεπιδερμидική συμβολή και άνω χόριο, που δεν είναι ορατές με γυμνό οφθαλμό (24). Τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά μιας δερματικής βλάβης σε συνδυασμό με τα λοιπά ευρήματα της κλινικής εξέτασης, το ιστορικό, ατομικό αναμνηστικό και την συνολική κλινική κατάσταση του ασθενούς ολοκληρώνουν την δερματολογική εξέταση και βοηθούν στην διεξαγωγή μιας ασφαλούς διαφορικής διάγνωσης ή και διάγνωσης σε αρκετές κλινικές περιπτώσεις, χωρίς την χρήση περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων. Αν και η αρχική εφαρμογή της δερματοσκόπησης ήταν οι όγκοι του δέρματος (25), πλέον ο σύγχρονος δερματολόγος χρησιμοποιεί το «στηθοσκόπιο» του, δηλαδή το δερματοσκόπιο στην αξιολόγηση κάθε δερματικής βλάβης. Έτσι σήμερα, ολοένα και περισσότερα στοιχεία υπογραμμίζουν τον σπουδαίο ρόλο της δερματοσκόπησης στις φλεγμονώδεις και λοιμώδεις δερματοπάθειες (26,27). Καθιερώθηκε η αναφορά στον όρο “inflammoscopy” (27), δηλαδή την δερματοσκόπηση των φλεγμονωδών δερματοπαθειών. Συνεπώς η δερματοσκόπηση πλέον χρησιμοποιείται και στην αξιολόγηση φλεγμονωδών δερματοπαθειών, όπως ο ομαλός λειχήνας.

2.2 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

Το πιο συχνό δερματοσκοπικό εύρημα του ομαλού λειχήνα είναι το δίκτυο του Wickham (Wickham Striae, WS). Το δίκτυο Wickham περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Louis Frédéric Wickham το 1895 (28), θεωρείται παθογνωμονικό για τον ομαλό λειχήνα και συμβάλει σημαντικά στη διαφορική διάγνωση, ωστόσο η απουσία αυτού δεν αποκλείει την διάγνωση.

Πρόκειται για λευκές δικτυωτές ή δαντελοειδείς δομές που μπορεί να αναπτύσσουν λεπτές ή ευρείες διακλαδιζόμενες προσεκβολές πάνω στη λεία επιφάνεια των πλακών του ΟΛ (26,29). Ιστολογικά αντιστοιχεί σε εστιακή υπερκόκκωση και ακάνθωση. Άλλα δερματοσκοπικά πρότυπα του WS είναι απλές λευκές γραμμές (ευθείες ή κυκλικές), λευκές γραμμές που ξεκινούν από το κέντρο και εκτείνονται προς την περιφέρεια (σαν ακτίνες), διακλαδιζόμενες λευκές γραμμές (arborizing), θυλακικές λευκές κηλίδες (ροζέτες), φύλλα,

έναςτρος ουρανός (συρρέουσες ή θυλακικές λευκές τελείες), πέπλο ή δίκην φύλλου (με δευτερογενείς γραμμικές διακλαδώσεις από το κέντρο του WS, που ενώνονται μεταξύ του και μιμούνται την κρυσταλλική δομή του χιονιού) (9, 30-39) (πίνακας 2) (40). Κατά περιπτώσεις, όπως σε σκουρόχρωμους φωτότυπους μπορεί το δίκτυο να μην είναι λευκό αλλά κίτρινο ή μπλε (30,41). Στον στοματικό βλεννογόνο το WS παρουσιάζεται ως δαντελοειδείς ή δενδροιτικές δομές (42,43).

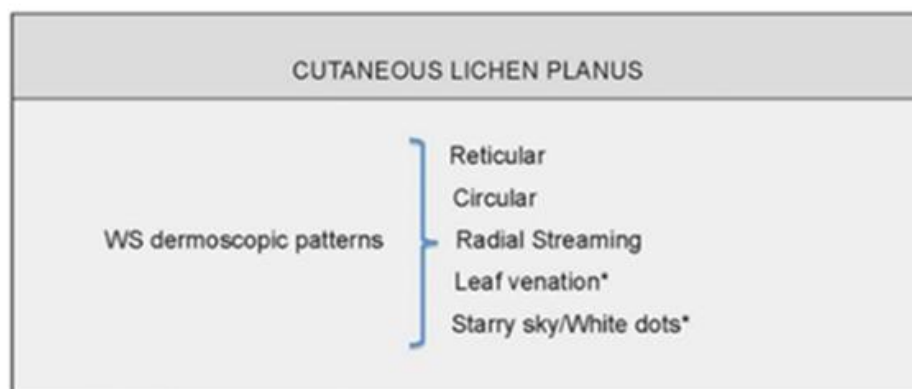
Επιπρόσθετα δερματοσκοπικά ευρήματα είναι τα στιγμοειδή και γραμμοειδή αγγεία στην περιφέρεια του δικτύου (26) Ακόμη, κατά την δερματοσκόπηση βλαβών ΟΛ μπορεί να εντοπιστεί ιώδες, κόκκινο, ροζ, καφέ, κίτρινο φόντο καθώς και παρουσία μελαγχρωματικών δομών (τελείες, σφαιρίδια ή/και δίκτυο ή σαν σύννεφα περιοχές) (30).

Το 2021 δημοσιεύτηκε από την ομάδα των S. Dash και συνεργατών μια σειρά 14 ασθενών με κλασσικό ομαλό λειχήνα και φωτότυπο IV ή V, σύμφωνα με τα ευρήματά τους στο 95% των ασθενών παρατήρησαν λαμπιρίζουσες λευκές δομές (Shiny White Structures – SWS) με πολωμένο φως και στο 85% των ασθενών βρήκαν το WS με μη πολωμένο φως (Πίνακας 3) (44). Συμπερασματικά το WS είναι πιο ευδιάκριτο με μη πολωμένο φως και είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε πολωμένο και μη πολωμένο φως κατά τη δερματοσκόπηση τέτοιων βλαβών, προκειμένου να διαφοροδιαγιγνώσκουμε τις SWS από το WS (44).

Σε ότι αφορά τους ασθενείς με σκούρο φωτότυπο, η δερματοσκόπηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση του WS, το οποίο δεν είναι εύκολα ορατό με γυμνό οφθαλμό σε αυτούς. Επίσης παρατηρείται απουσία των αγγειακών προτύπων που προαναφέρθηκαν, γεγονός που μπορεί να παρερμηνευθεί ως απουσία φλεγμονής. Οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να έχουν υπόψιν ότι το WS μπορεί να παρουσιαστεί με ποικίλα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά και χρωματικά πρότυπα στους ασθενείς αυτούς (45).

Πίνακας 2. Δερματοσκοπικά πρότυπα WS (40)

Table 1: CUTANEOUS LICHEN PLANUS



*New dermoscopic patterns

Paula Friedman et al. (40)

Πίνακας 3. Δερματοσκοπικά ευρήματα ΟΛ με πολωμένο και μη πολωμένο (44)

Table 1 Dermoscopic features of lichen planus under polarized and nonpolarized mode.

Serial number	Seen only under polarized mode	N (%)	Better visualized under contact polarized mode	N (%)	Better visualized under contact nonpolarized mode	N (%)
					Scales	56 (73.6)
					(i) Colour	56 (73.6)
					(ii) Distribution*	
			Vascular structures	43 (56.6)		
			(i) Morphology			
			(a) Dotted vessels	43 (56.6)		
			(b) Linear curved vessels	08 (10.5)		
			(ii) Distribution			
			(a) Uniform	15 (19.7)		
			(b) Peripheral	16 (21.0)		
			(c) Nonspecific	12 (15.7)		
					Specific clues:	
					Wickham striae	65 (85.5)
	Other structures					
	(i) SWS		(i) Blue-grey dots/globules/peppering	9 (11.8)	(i) Comedo-like opening	41 (53.9)
	(a) Rosettes	28 (36.8)	(ii) Structureless area (background colour)	65 (85.5)	(ii) Keratotic plug	34 (44.7)
	(b) Shiny white lines	61 (80.2)	(a) Pink/pink-brown/pink-grey	47 (61.8)	(iii) Linear irregular crypt	27 (35.5)
	(c) Shiny white structureless areas	11 (14.4)	(b) Grey/blue-grey	11 (14.4)		
	(d) Pericomedonal/periadnexal SWS	36 (47.3)	(c) Brown-grey/brown	7 (9.2)		
	(e) Multicolour pattern	2 (2.6)				
	(ii) Blink sign	53 (69.7)				

S. Dash et al. (44)

2.3 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

Ο υπερτροφικός ομαλός λειχήνας δερματοσκοπικά χαρακτηρίζεται από φαγεσωροειδείς δομές (“comedo-like”), που είναι γεμάτες με κιτρινωπά κεράτινα βύσματα, δομές δίκην κόκκου καλαμποκιού (“corn pearls”) και μπλε-γκρι σφαιρίδια (46). Το πιο συχνό δερματοσκοπικό εύρημα είναι οι περιφερικές ραβδώσεις που εμφανίζονται ως υπόλευκες ακτινωτές γραμμές με περιοχές λευκής πέρλας, σύμφωνα με μια μελέτη του 2019. Ιστοπαθολογικά οφείλονται στη συμπαγή ορθοκεράτωση πάνω από τις στιβάδες του δέρματος με υπερκόκκωση, ακάνθωση και χοριακή ίνωση. Τα φαγεσωροειδή ανοίγματα (“comedo-like openings”) ιστολογικά σχετίζονται με διαστολή του πόρου, παρουσία κεράτινου βύσματος εντός αυτού και συνοδό υπερκόκκωση. Τα μπλε-γκρι σφαιρίδια αντιστοιχούν στην παρουσία φορτωμένων με χρωστικές μελανινοφάγων στο χόριο και υποδηλώνουν βλάβη σε υποστρόφη. Άλλα δερματοσκοπικά ευρήματα που έχουν περιγραφεί στον υπερτροφικό ΟΛ είναι κιτρινόχρωες δομές, καφέ-μαύρα σφαιρίδια, κρούστες, διαβρώσεις, λέπια, λευκές περιοχές χωρίς δομές και κεντρική υπερμελάγχρωση (30,47). Οι κιτρινόχρωες δομές υποδηλώνουν σπογγίωση και κενотоπιώδη εκφύλιση της βασικής στιβάδας. Τα καφέ-μαύρα σφαιρίδια σχετίζονται με την παρουσία μελανινοκυττάρων στην επιδερμίδα. Επίσης μπορεί να παρατηρηθούν μη ειδικά αγγειακά ευρήματα, όπως κόκκινα σφαιρίδια, που οφείλονται σε διατεταμένα τριχοειδή, σπειραματοειδή, γραμμικά και στικτά αγγεία. Ενώ λόγω της υπερκείμενης υπερκεράτωσης που χαρακτηρίζει τον υπερτροφικό ΟΛ συχνά το WS είναι μη ορατό (37,41, 47,48).

2.4 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

Ο μελαγχρωματικός ομαλός λειχήνας (ΜΟΛ) είναι μια μορφή ομαλού λειχήνα που αφορά κυρίως τους σκουρόχρωμους φωτότυπους και εμφανίζεται με την μορφή σκούρων καφέ έως και γκρι μελαγχρωματικών κηλίδων στις φωτο-εκτεθειμένες περιοχές, όπως το πρόσωπο και τον λαιμό (49). Το 2013 περιγράφηκε για πρώτη φορά μια μορφή θυλακικού λειχήνα και πρόσθιας ινωτικής αλωπεκίας σε συνύπαρξη με ΜΟΛ (50,51). Σε αντίθεση με τον κλασσικό ομαλό λειχήνα και τις άλλες μορφές του, στον μελαγχρωματικό ΟΛ δεν παρατηρείται κατά την δερματοσκόπηση το WS, ούτε το αγγειακό

περιφερικό πρότυπο, λόγω της λεπτότερης επιδερμίδας (52). Η βιβλιογραφία για την δερματοσκόπηση του μελαγχρωματικού ΟΛ είναι περιορισμένη, ωστόσο πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια μελέτη - παρουσίαση σειράς 23 περιστατικών από τους Chamli Amal, Malek Mrad και συνεργάτες, που παρουσιάζει τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά 23 κλινικών περιπτώσεων σε συσχέτιση με την ιστοπαθολογική εικόνα (πίνακας 2). Η δημοσίευση αυτή προτείνει ως ειδικό δερματοσκοπικό εύρημα του χρόνιου ΜΟΛ τις κηλίδες (blotches) (53). Στην δερματοσκόπηση του ΜΟΛ έχουν περιγραφεί διάφορα μελαγχρωματικά πρότυπα όπως η διάχυτη, χωρίς δομή καφέ μελάγχρωση, γκρι, μπλε ή καφέ τελείες (σημείο αλατοπίπερου – “peppering”) ή σφαιρίδια (clods) (54), δακτυλιοειδής/ περιτριχοθυλακική μελάγχρωση, γραμμοειδής, δίκην πλακόστρωτου μελάγχρωση και ο συνδυασμός προτύπων (δηλαδή διάχυτες καφεοειδή περιοχές και πρότυπο σαν τελείες) (54, 55). Ο ΜΟΛ μπορεί να εμφανιστεί με περισσότερα από ένα μελαγχρωματικά πρότυπα (54,56). Τα μελαγχρωματικά αυτά πρότυπα του ΜΟΛ ιστοπαθολογικά αντιστοιχούν στην ακράτεια μελανίνης και στην παρουσία μελανινοφάγων στο χόριο (52).

2.5 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ- ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

Ο μελαγχρωματικός – ανάστροφος ομαλός λειχήνας (ΜΑΟΛ) περιγράφηκε πρώτη φορά το 2001, αποτελεί μια σπάνια υποκατηγορία του μελαγχρωματικού ομαλού λειχήνα και που εμφανίζεται ως υπερμελαγχρωματικές κηλίδες ή πλάκες σε πτυχές και καμπτικές επιφάνειες (6,57). Σύμφωνα με την μελέτη των Chamli Amal, Malek Mrad και των συνεργατών τους, ως παθογνωμονικό δερματοσκοπικό εύρημα για τον μελαγχρωματικό - ανάστροφο ομαλό λειχήνα (ΜΑΟΛ) προτείνεται το κυανόλευκο πέπλο που σχετίζεται με ροζέτες (rosettes) (πίνακας 4) (53). Επίσης άλλα δερματοσκοπικά ευρήματα που έχουν συσχετιστεί με ΜΑΟΛ είναι καφέ χωρίς δομή περιοχές, διάχυτο σημείο αλατοπίπερου (“peppering”), περιθυλακική μελάγχρωση, γκρι, μπλε ή καφέ τελείες (dots) και φωλίες (clods) ομαδοποιημένες σε δικτυωτό, γραμμικό, πλακόστρωτο πρότυπο και συνδυασμός προτύπων (πίνακας 5) (40). Κατά τη δερματοσκόπηση του ΜΑΟΛ δεν παρατηρούνται το WS και οι περιφερικές αγγειακές δομές, σε αντίθεση με τον ΜΟΛ. Τα δερματοσκοπικά ευρήματα του ΜΑΟΛ φαίνεται να

σχετίζονται με την πρόγνωση, καθώς η μελάγχρωση που βρίσκεται βαθύτερα συνήθως εμφανίζεται δερματοσκοπικά με το πρότυπο τελειών (dots) (58).

Πίνακας 4. Δερματοσκοπικά και Ιστοπαθολογικά ευρήματα (53)

Table 1. Dermoscopic and Histopathological Features of the Study Population.

Dermoscopic features	Frequency
Dots and globules:	23
Dark brown color	15
Light brown	5
Gray	3
Patterns	
Speckled	4
Dotted	2
Reticulated	9
Diffuse	2
Circular	1
Hem-like	
Accentuation of the normal pseudo reticular pigmentary network	12
Sparing of hair follicle openings	23
Targetoid structure	3
A blue-white veil	5
Rosettes	5
Blotches	7
Erythema	4
Telangiectasias	7
Histopathological features:	23
Pigment incontinence and melanophages	15
Severe	8
Mild	
An upper dermis band-like lichenoid infiltrate	8
Superficial perivascular infiltrate	13

Amal Chamli et al. (53)

Πίνακας 5. Δερματοσκοπικά πρότυπα μελαγχρωματικού ανάστροφου ΟΛ (40)

Table IV: LICHEN PLANUS PIGMENTOSUS INVERSUS

LICHEN PLANUS PIGMENTOSUS INVERSUS
❖ Diffuse pattern ❖ Dotted pattern ❖ Mixed pattern

Paula Friedman et al. (40)

2.6 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΟΥΣ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

Ο δακτυλιοειδής ομαλός λειχήνας (ΔΟΛ) ή δακτυλιοειδής ατροφικός ομαλός λειχήνας είναι μια από τις πιο σπάνιες μορφές του ομαλού λειχήνα (59). Συνήθως οι βλάβες παρουσιάζουν κεντρική ατροφία. Οι πιο συχνές περιοχές εμφάνισης του ΔΟΛ είναι η γεννητική και η περιγεννητική, ωστόσο μπορεί να εκδηλωθεί και σε άλλα μέρη του σώματος όπως τα άκρα (60). Ιστοπαθολογικά χαρακτηρίζεται από απώλεια ελαστικών ινών προκαλούμενη από λεμφοκύτταρα (61). Κατά την δερματοσκόπηση μπορούμε να εντοπίσουμε κυκλικό WS, μελαγχρωματικές περιοχές χωρίς δομές, περιθυλακική μελάγχρωση, γραμμική μελάγχρωση, σημείο αλατοπίπερου (“peppering”) περιφερικά, κόκκινες τελείες περιφερικά σε ροζ, ερυθρό, καφέ ή κίτρινο φόντο (6,9,54, 56,62)

2.7 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

Ο ακτινικός ομαλός λειχήνας είναι μια σπάνια μορφή ΟΛ, που αφορά σκουρόχρωμους φωτότυπους και εμφανίζεται σε ηλιο- εκτεθειμένες περιοχές. (6). Το 2024 δημοσιεύτηκε μια σειρά 16 ασθενών με Ακτινικό ομαλό λειχήνα και παρουσιάστηκαν τα δερματοσκοπικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά τους (Πίνακας 6) (63). Με τη δημοσίευση αυτή προτάθηκαν νέα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά ανάλογα τον τύπο του ΟΛ, την κατανομή και τον φωτότυπο (63). Κατά τη δερματοσκόπηση παρατηρούνται διάχυτα το πρότυπο αλατοπίπερου (“peppering pattern”) σε καφέ φόντο, λευκό – κίτρινο – γαλαζωπό WS, λευκές κυκλικές, δικτυωτές δομές (6,9,63).

Πίνακας 6. Δερματοσκοπικά και ιστολογικά ευρήματα Ακτινικού ΟΛ (63)

Table 1. Dermatoscopic differences between Actinic Lichen Planus and classic Lichen Planus with a dermatoscopy pathology correlation

Dermoscopic signs	Classic lichen planus	Actinic lichen planus	Dermatopathologic correlations of dermatoscopic findings
Wickham striae (18)	Polymorphic pearly white structures (rounded, arboriform, reticular, annular), Blue-white	White circular and reticular	Hypergranulosis with acanthosis
• Dark phototype (19,20)		White-yellow-bluish WS	
Pigmented structures	Active lesions	Active and late lesions	
Annular granular pattern	Not described	Pigmented melasma-like ALP	Melanin incontinence
Dots inside circles	Not described	Pigmented melasma-like ALP	
Eccentric pigmentation on circles	Not described	Pigmented melasma-like ALP	
Blue-gray granules	Yes	Pigmented melasma-like ALP	
Periosteal brown dots and brown structureless areas with ostial sparing (10)	Not described	Pigmented ALP	
Hypopigmentation lacking skin creases	Not described	Pigmented melasma-like ALP	Irregular acanthosis and hypergranulosis
Perifollicular white halos	Not described	AALP and plaque-like ALP	Early perifollicular fibrosis
Follicular plugs	Hypertrophic forms of LP	AALP and plaque-like ALP	Follicular hyperkeratosis
White scales	Yes, may be diffuse obscuring the visibility of shiny white structures and Wickham striae	Fine scales	Orthokeratosis
Shiny white structures (19)	Reticular lines, and structureless areas	Reticular lines and perifollicular in AALP and plaque-like ALP	Dermal fibrosis
Circumferential radial lines at the periphery	Not described	AALP and plaque-like ALP	Peripheral extension of the basal vacuolization, the dermal inflammatory infiltrate and the pigmentary incontinence
Pigmented dots arranged in parallel lines	Not described	AALP and plaque-like ALP	Melanin incontinence
Vascular structures	Radial capillaries with dotted, globular and/or linear vessels, mainly localized at the periphery of the lesion (and less commonly showing a perifollicular or a diffuse pattern) (21)	Dotted vessels in Dyschromic ALP	Dermal vessels
Background	Pink violet, reddish and blue-gray, brown or yellow background	Light to dark brown violaceous blue-gray background	

ALP = Actinic Lichen Planus; AALP = annular Actinic Lichen Planus; LP = Lichen Planus.

Awatef Kelati et al. (63)

2.8 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΛΑΜΟΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

Ο παλαμοπελματιαίος ομαλός λειχήνας (ΠΠΟΛ) χαρακτηρίζεται από στρογγυλές κιτρινωπές περιοχές με περιφερικές προσεκβολές (30), που δημιουργούν εμφάνιση δίκην άστρου και αντιστοιχεί στην ιδιαίτερη εικόνα του WS σε παλάμες και πέλματα (64). Σε αντίθεση με τον κλασσικό ΟΛ στις

περισσότερες βλάβες ΠΠΟΛ δερματοσκοπικά δεν παρατηρούμε WS, λόγω της παχιάς κεράτινης στιβάδας παλαμών-πελμάτων (48). Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί WS με κίτρινο χρώμα σε αυτές τις θέσεις (65). Σύμφωνα με μια κλινικο-επιδημιολογική μελέτη του το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του ΠΠΟΛ είναι η διάχυτη λευκή απολέπιση. Επίσης περιγράφηκαν το κιτρινόχρωο και λευκό λέπτι, ερυθηματώδες φόντο και κεντρικά κεράτινα βύσματα που περιβάλλονται από ομόκεντρη απολέπιση (66). Άλλο δερματοσκοπικό εύρημα που έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία είναι οι μαύρες κηλίδες (“patches”) στις παλάμες με τον όρο «δίκην στριφώματος» πρότυπο (“hem-like pattern”), που οφείλονται στην εναπόθεση μελανίνης κατά μήκος των ακρολοφιών (67). Ενώ για τον πελματιαίο ομαλό λειχήνα περιγράφονται ως δερματοσκοπικά ευρήματα η απολέπιση και το δικτυωτό πρότυπο (47).

2.9 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΜΦΙΓΟΕΙΔΟΥΣ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

Ο πεμφιγοειδής ομαλός λειχήνας δερματοσκοπικά χαρακτηρίζεται από ημιδιαφανείς ημισφαιρικές βλάβες με κεντρικό λακκάκι και ακτινωτό WS. Το κεντρικό λακκάκι αποτελείται από λευκά σφαιρίδια που αντιστοιχούν στη χοάνη/άνωτερο τμήμα του τριχοθυλακίου. Τα θυλακικά ανοίγματα διατηρούνται. Η κυρίαρχη δομή στην γύρω περιοχή αντιστοιχεί στο ενδοεπιδερμίδικο τμήμα του ιδρωτοποιού αδένα (ακροσυρίγγιο) (68). Τα όρια των βλαβών είναι συνήθως ομαλά (69).

2.10 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

Ο γραμμικός ομαλός λειχήνας είναι μια σπάνια μορφή του ομαλού λειχήνα που αφορά λιγότερο από το 1% του συνόλου των ασθενών με ομαλό λειχήνα και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος. Ωστόσο, στην Ιαπωνία αυτή η μορφή αποτελεί περισσότερο από το 10% του συνόλου (70). Ο γραμμικός ομαλός λειχήνας εμφανίζεται με γραμμικό πρότυπο με το φαινόμενο Koebner ή με δερμοτομιακό/ Blaschkoid πρότυπο (71). Το ζωστηροειδές πρότυπο μπορεί να εμφανιστεί σε περιοχές όπου έχουν προσβληθεί πρόσφατα από ερπητική λοίμωξη ή de novo σε υγιείς περιοχές (72). Μερικές φορές συνυπάρχει ο γραμμικός ομαλός λειχήνας με τον κλασσικό ομαλό λειχήνα σε διαφορετικές περιοχές. Επίσης έχει περιγραφεί ομόπλευρη βλεννογονική συμμετοχή (73,74).

Κατά τη δερματοσκόπηση του ζωστηροειδούς γραμμικού ομαλού λειχήνα δεν παρατηρούνται το WS και τα αγγειακά πρότυπα που παρατηρούνται στον κλασσικό ΟΛ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προσβάλλεται ο κορμός. Αντίθετα, ο γραμμικός ομαλός λειχήνας, που ακολουθεί τις γραμμές κατά Blaschko, όταν προσβάλει τα άκρα και το πρόσωπο έχει τα ίδια δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά με τον κλασσικό ομαλό λειχήνα (75).

2.11 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ

Κατά τη δερματοσκόπηση του ομαλού λειχήνα στον στοματικό βλεννογόνο παρατηρείται φόντο αχνό ροζ, αχνό κόκκινο, βιολετί, ροζ καφέ χρώμα (76). Το WS δεν παρατηρείται σταθερά στις βλάβες ομαλού λειχήνα στον στοματικό βλεννογόνο. Όταν παρατηρείται εμφανίζεται με χρώμα ως λαμπιρίζον λευκό έως γκρι λευκό στις παρειές και στα χείλη, γκρι-λευκό έως υποκύανο-λευκό στην γλώσσα και από λευκό έως καφέ στα χείλη. Το WS μπορεί να παρουσιαστεί με διάφορα πρότυπα, δικτυωτό-δαντελωτό λευκό στις παρειές, κυκλικό και χωρίς δομές σαν πέπλο στη ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας, γραμμικό – δικτυωτό ή δίκην φυλλώματος ή ακτινωτό στα χείλη. Επίσης μπορεί να εντοπιστούν αγγεία σαν τελείες, γραμμικά ή δίκην φουρκέτας στα χείλη, δίκην ανεμώνης (77). Επίσης παρατηρούνται γκρι-μαύρες και καφέ μελαγχρωματικές δομές περιφερικά ως σφαιρίδια, κηλίδες ή ραβδώσεις, που αντιστοιχούν στην παρουσία μελανινοφάγων. Επίσης κατά την δερματοσκόπηση με πολωμένο φως παρατηρούνται ροζέτες (“rosettes”) ως 4 λευκές τελείες που ομοιάζουν με ένα τετράφυλλο τριφύλλι, που αντιστοιχούν σε ομόκεντρο υλικό και τους εκκρινείς πόρους στο επίπεδο της χοάνης ή σε περιθυλακική ομόκεντρη ίνωση (78).

2.12 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ

Ο ομαλός λειχήνας στον γυναικείο γεννητικό βλεννογόνο εμφανίζεται κυρίως στις περι ή μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Οι κλινικές μορφές του ομαλού λειχήνα στον γυναικείο γεννητικό βλεννογόνο είναι διαβρωτικός, βλατιδοπλακώδης και σπάνια υπερτροφικός (79). Η εμφάνιση βλαβών κλασσικού ΟΛ στην γεννητική περιοχή είναι σπάνια. Στα χείλη του αιδοίου οι βλάβες μπορεί να εμφανιστούν με βαθύ κόκκινο χρώμα ή κόκκινο-καφέ σε αντίθεση με το τυπικό ιώδες χρώμα του ΟΛ. Η υπερκερατωσική παραλλαγή

εκδηλώνεται με λευκές βλατίδες ή πλάκες με ακανόνιστα όρια και παχιά ακανόνιστη επιφάνεια. Η διαβρωτική μορφή είναι η πιο σημαντική και αποστρεπτική μορφή του ομαλού λειχήνα στο αιδοίου (80,81).

Στον ανδρικό βλεννογόνο ο ομαλός λειχήνας κλινικά παρουσιάζεται ως σκούρο κόκκινο-καφέ βλατίδες και πλάκες χωρίς απολέπιση ή ως ατροφικές διαβρώσεις (80). Οι βλάβες του ομαλού λειχήνα είναι ιώδεις έως λευκές στη περιφέρεια ενώ στο κέντρο είναι υπερμελαγχρωματικές και εμφανίζονται σαν τόξο και σαν ραβδώσεις. Επίσης μπορεί να αναπτυχθούν δακτυλιοειδείς βλάβες. Έχει περιγραφεί ως σύνδρομο η συνύπαρξη βλαβών στον γεννητικό βλεννογόνο του πέους και στον στοματικό βλεννογόνο των ούλων (82).

Οι μακροχρόνιες διαβρώσεις έχουν συσχετιστεί με την ανάπτυξης φίμωσης και SCC (83).

Δερματοσκοπικά παρατηρούμε αχνό ή έντονο κόκκινο φόντο (84). Το WS είναι το χαρακτηριστικό δερματοσκοπικό εύρημα, αν και δεν είναι σταθερό χαρακτηριστικό (85). Στον γεννητικό βλεννογόνο το WS εμφανίζεται σαν περλέ λευκάζουσες δομές με διαφορετικά πρότυπα, όπως δικτυωτό, ακτινωτό, δακτυλιοειδές, σφαιροειδές, ομογενές, στιγμοειδές/ δίκην έναστρου ουρανού, μπλε-λευκό ή γκρι-λευκό δίκην πέπλου ή με συνδυασμό προτύπων (86). Ιστολογικά το WS αντιστοιχεί με υπερκόκκωση (87). Επίσης παρατηρούνται αγγειακές δομές σαν τελείες, γραμμικά, δίκην φουρκέτας διάσπαρτα στη βλάβη ή με κατανομή ακτινωτή ή παράλληλη στην περιφέρεια των βλαβών ή σπανίως περιθυλακική (88). Οι μελαγχρωματικές δομές εμφανίζονται σαν γκρι-μπλε τελείες/ σφαιρίδια δίκην αλατοπίπερου (“peppering”). Τέλος, έχουν επίσης παρατηρηθεί διαβρώσεις και φαγεσωροειδή ανοίγματα (84).

2.13 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΥΛΑΚΙΚΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ

Κατά την τριχοσκόπηση στον κλασσικό θυλακικό λειχήνα τα πιο συχνά ευρήματα είναι η απουσία θυλακικών ανοιγμάτων, η περιθυλακική απολέπιση, περιθυλακικό ερύθημα και γαλακτώδεις-κόκκινες περιοχές. Τα δερματοσκοπικά ευρήματα διαφέρουν ανάλογα το στάδιο και τον βαθμό ενεργότητας της νόσου. Στα αρχικά στάδια, η περιθυλακική φλεγμονή οδηγεί στην εμφάνιση λευκού-γκρι λεπτιού, που σχετίζεται με περιθυλακικό ερύθημα και αγγεία σαν δενδρίτες. Στον θυλακικό ομαλό λειχήνα συνήθως τα τριχοθυλάκια προσβάλλονται από την φλεγμονή επιλεκτικά και χωρίς την προσβολή του

ενδοθυλακικού επιθηλίου, γεγονός που αποτελεί σημαντικό διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο (97).

Ο κλασσικός θυλακικός ομαλός λειχήνας μπορεί να εμφανιστεί ως ασημί – λευκές σωληνοειδείς ή δίκην κολάρου δομές (89). Επίσης έχει περιγραφεί ένα νέο δερματοσκοπικό πρότυπο με σωληνοειδή απολέπιση σε ασθενείς με θυλακικό ομαλό λειχήνα και πρόσθια ινωτική αλωπεκία. Κατά την δερματοσκόπηση χωρίς διαθλαστικό υγρό παρατηρείται το σημείο του διπλού δακτυλίου (“double ring sign”), το οποίο αποτελείται από δύο ασημί δακτυλίους απολέπισης γύρω από το τριχοθυλάκιο (90).

Στο ινωτικό στάδιο, παρατηρούνται λευκές ή γαλακτώδεις-κόκκινες περιοχές, που καλύπτονται από τις κλασσικές ακανόνιστες λευκές τελείες. Επίσης παρατηρούνται μπλε-ιωδείς περιοχές και μπλε-γκρι τελείες, που αντιστοιχούν σε περιθυλακική μελάγχρωση (98). (Πίνακας 7) (40).

Σύμφωνα με δημοσίευση σειράς 37 κλινικών περιστατικών με μελαγχρωματικό ομαλό λειχήνα σε ασθενής με πρόσθια ινωτική αλωπεκία, περιγράφηκαν δερματοσκοπικά πρότυπα μελαγχρωματικού ομαλού λειχήνα στο πρόσωπο. Προτάθηκαν ως σημαντικά στοιχεία για την διάγνωση του μελαγχρωματικού ομαλού λειχήνα η ύπαρξη στιγμοειδούς προτύπου και η απώλεια τριχών προσώπου.. (Πίνακας 8) (91).

Πίνακας 7. Δερματοσκοπικά ευρήματα θυλακικού ΟΛ (40)

Table II: LICHEN PLANOPILARIS

LICHEN PLANOPILARIS
❖ Irregular alopecic areas ❖ Perifollicular whitish-gray scaling ❖ Perifollicular erythema (arboriform vessels) ❖ Absence of follicular openings ❖ Follicular plugging

Paula Friedman et al. (40)

Πίνακας 8. Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά ΜΟΛ σε πρόσθια ινωτική αλωπεκία (91)

Table 1 Summary of clinical and dermoscopic features of lichen planus pigmentosus in frontal fibrosing alopecia patients and its differential diagnoses

	Clinical features	Dermoscopy
Lichen planus pigmentosus	Blue-grey to brownish-black diffuse hyperpigmentation, occasionally with a reticulate pattern, involving face and neck	Pseudonetwork pattern Blue-grey dots arranged in circles Speckled blue-grey dots Dotted pattern Rhomboids and asymmetric pigmented follicular openings Focal and diffuse erythema and telangiectatic vessels Loss of facial vellus hairs

R. Pirmez et al. (91)

2.14 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΜΑΛΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ ΟΝΥΧΟΣ

Ο ομαλός λειχήνας όνυχος εμφανίζεται στο 10% του συνόλου των ασθενών με ομαλό λειχήνα σε άλλες θέσεις (92). Κλινικά παρουσιάζεται πιο συχνά στα νύχια των χεριών με λέπτυνση, ευθραυστότητα και καταστροφή της ονυχιαίας πλάκας, ονυχόλυση, τραχυονυχία και υπονύχια υπερκεράτωση (93,92). Η ονυχόλυση, η χρωμονυχία και η υπονύχια υπερκεράτωση οφείλονται στην συσσώρευση υλικού στην κοίτη του όνυχος (94). Κατά την ονυχοσκόπηση ανευρίσκονται περύγιο, ερυθματώδη μπαλώματα (patches), ερυθρονυχία, μελανονυχία, ατροφία, ονυχομάδηση, βοθρία (pitting nail), γραμμή Beau ο. (Πίνακας 9) (40).

Ωστόσο, με βάση τα όσα γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα δεν έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία WS στο τριχωτό κεφαλής και στα νύχια. Το 2023 δημοσιεύτηκαν δύο κλινικές περιπτώσεις, από την Laoura Fagotto και τους συνεργάτες της, που πραγματεύονται την παρουσία WS σε ασυνήθεις περιοχές, όπως στο τριχωτό κεφαλής και στα νύχια. Οι κλινικοί ιατροί δεν θα πρέπει να παραλείπουν την εξέταση αυτών των ανατομικών θέσεων (τριχωτό κεφαλής, νύχια) όταν υπάρχει υποψία ΟΛ (95).

Πίνακας 9. Δερματοσκοπικά ευρήματα ομαλού λειχήνα όνυχος (40)

Table III: NAIL LICHEN PLANUS

NAIL LICHEN PLANUS	
Matrix Compromise	Nail Bed Compromise
❖ Plate nail destruction	❖ Onycholysis
❖ Trachyonychia	❖ Chromonychia
❖ Anonychia	❖ Subungual hyperkeratosis
❖ Dorsal pterygium	
❖ Longitudinal ridging	
❖ Red lunula	
❖ Pitting	

Paula Friedman et al. (40)

Έχει αποδειχτεί ότι το WS εξαφανίζεται μετά από θεραπεία του ομαλού λειχήνα, κυρίως στην κλασσική μορφή, όταν αυτό υπάρχει εξ αρχής. Ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο στον μελαγχρωματικό ομαλό λειχήνα, όπου έχει παρατηρηθεί ότι το WS μπορεί να απουσιάζει ενώ τα μελαγχρωματικά πρότυπα συχνά παραμένουν. Επίσης οι μελαγχρωματικές δομές μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των όψιμων σταδίων παρά τη θεραπεία (96). Έχει παρατηρηθεί ότι το WS είναι παρόν σε ενεργές βλάβες, ενώ μετά από θεραπεία υποστρέφει. Αντίθετα τα μελαγχρωματικά πρότυπα φαίνεται να παραμένουν ή να εμφανίζονται σε προχωρημένα στάδια παρά τις θεραπείες. Συνεπώς η δερματοσκόπηση και η παρουσία δικτύου Wickham ή μελαγχρωματικών προτύπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της πρόγνωσης και της ανταπόκρισης στη θεραπεία (96).

3. ΜΕΘΟΔΟΣ

Συγκεντρώθηκαν 12 κλινικές περιπτώσεις από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της Δερματολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου υπηρετώ ως ειδικευόμενη ιατρός Δερματολογίας από τον 02/2024. Οι κλινικές αυτές περιπτώσεις διαγνώσθηκαν κλινικά με ομαλό λειχήνα και επιβεβαιώθηκαν ιστολογικά από το 2022 έως το 2024 από

την επιμελήτρια Α΄ ιατρό κα Κουμάκη Δήμητρα και τους συνεργάτες της στο τακτικό εξωτερικό ιατρείο της Δερματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ. Τα περιστατικά παραχωρήθηκαν για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μου στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Δερματοσκόπηση» του ΑΠΘ, στο οποίο τελώ μεταπτυχιακή φοιτήτρια, με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Καθηγητή Κρασαγάκη Κωνσταντίνου - Καθηγητής Δερματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και της κας Κουμάκη Δήμητρας- Επιμελήτρια Α΄ Δερματολογικής κλινικής ΠΑΓΝΗ.

Οι κλινικές περιπτώσεις ταξινομήθηκαν με βάση τις διάφορες μορφές του ομαλού λειχήνα και μελετήθηκαν ως προς την κλινική εικόνα, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, τα δερματοσκοπικά και τα ιστοπαθολογικά ευρήματα .

Οι δερματοσκοπικές εικόνες ελήφθησαν με τη χρήση δερματοσκοπίου χειρός DermLite κατά την παρακολούθηση των ασθενών (follow up) στο τακτικό εξωτερικό δερματολογικό ιατρείο του ΠΑΓΝΗ, με την συγκατάθεση των ασθενών. Συνεπώς ως επί το πλείστον οι δερματοσκοπικές εικόνες και τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά, που παρουσιάζονται στη παρούσα μελέτη αφορούν σε ασθενείς υπό θεραπεία για ομαλό λειχήνα ιστολογικά επιβεβαιωμένο. Η αξιολόγηση των δερματοσκοπικών ευρημάτων είναι βασισμένη στα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του ομαλού λειχήνα που έχουν δημοσιευτεί έως και σήμερα στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, κάθε δερματοσκοπική εικόνα αναλύθηκε σχετικά με το κυρίαρχο αγγειακό πρότυπο που παρουσίαζε, ως προς την μορφολογία (στιγμοειδή ή γραμμικά αγγεία) και ως προς την κανανομή (ομοιόμορφη, περιφερική ή μη ειδικό πρότυπο). Επίσης, έγινε αναζήτηση του ειδικού ευρήματος του δικτύου Wickham, αλλά και άλλων δομών όπως των λαμπιριζουσών λευκών δομών (rosettes, λαμπιρίζουσες λευκές γραμμές, λαμπιρίζουσες λευκές χωρίς δομή περιοχές, πολύχρωμο πρότυπο), μπλε-γκρι σφαιριδίων/τελειών/δίκην αλατοπίπερου, χωρίς δομές περιοχών και του χρώματος του υπόβαθρου (ροζ/ροζ-καφέ/ροζ-γκρι, γκρι/μπλε-γκρι, καφέ-γκρι/καφέ).

Επιπλέον, όλα τα δείγματα των ιστοτεμαχίων δέρματος υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με αιματοξυλίνη/εωσίνη και συλλέχθηκαν ιστοπαθολογικές εικόνες σε συνεργασία με το Παθολογοανατομικό τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης. Έγινε προσπάθεια αξιολόγησης χαρακτηριστικών ιστοπαθολογικών

ευρημάτων και αντιστοίχισης αυτών με τις αντίστοιχες δερματοσκοπικές δομές, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία.

Τέλος, έγινε καταγραφή κλινικών και επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, όπως ηλικία, ανατομική θέση, κνησμός, ατομικό αναμνηστικό, φαρμακευτικό ιστορικό και θεραπευτική αντιμετώπιση.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν δώδεκα ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένο ομαλό λειχήνα, εκ των οποίων οι επτά (58%) ήταν άνδρες και οι πέντε (42%) ήταν γυναίκες. Οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα εργασία είχαν ηλικίες από 22 έως 78 ετών, μέσο όρο (mean) ηλικίας 57 και διάμεση (median) τιμή 59. Οι άνδρες είχαν μέσο όρο ηλικίας εμφάνισης 62 και οι γυναίκες 50 ετών.

Ός προς την εντόπιση, ένας ασθενής παρουσίασε βλάβες σε τριχωτό κεφαλής και στον γεννητικό βλεννογόνο, ένας ασθενής στον στοματικό βλεννογόνο, ένας μόνο στον κορμό, τέσσερις ασθενείς σε άνω και κάτω άκρα και πέντε ασθενείς παρουσίασαν εκτεταμένο ΟΛ σε κορμό, άνω και κάτω άκρα. (Πίνακας 10)

Υπάρχουν πολλές μορφές ομαλού λειχήνα, η πιο συχνή εκ των οποίων είναι ο κλασσικός ομαλός λειχήνας. Στη παρούσα εργασία ένας (8%) ασθενής είχε θυλακικό ΟΛ, ένας (8%) ασθενής ΟΛ στοματικού βλεννογόνου, ένας (8%) ασθενής παρουσίασε πεμφιγοειδή ΟΛ και τρεις (25%) ασθενείς υπερτροφικό ομαλό λειχήνα και έξι ασθενείς (50%) κλασσικό ομαλό λειχήνα. (Πίνακας 10,11).

Παρακάτω παρουσιάζονται οι 12 ασθενείς της παρούσας μελέτης, με σύντομο ιστορικό της νόσου, το ατομικό αναμνηστικό, την κλινική και δερματοσκοπική εικόνα, τα βασικά δερματοσκοπικά ευρήματα (Πίνακας 12), τις ιστολογικές εξετάσεις και τα βασικά παθολογοανατομικά ευρήματα (Πίνακας 13).

Ασθενής 1:

Ασθενής, θήλυ, 68 ετών με ατομικό αναμνηστικό (α/α) υποθυρεοειδισμός, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, πρώην καπνίστρια (20ry). Η ασθενής σε ηλικία 56 ετών παρουσίασε ουλωτική αλωπεκία με ερύθημα και περιθυλακικό λέπτι στο τριχωτό κεφαλής και βλάβες σε γεννητικό βλεννογόνο συμβατές με τριχοθυλακικό λειχήνα με συνοδό ήπιο κνησμό (2/10). Η ασθενής

αντιμετωπίστηκε με τοπικά κορτικοστεροειδή. Κατά την επανεκτίμηση (12/2024) ελήφθησαν δερματοσκοπικές εικόνες και η ασθενής παρουσιάζει βλάβες συμβατές με πρόσθια ουλωτική αλωπεκία και ομαλό θυλακικό λειχήνα, ενώ δεν έφερε βλάβες σε γεννητικό βλεννογόνο.

Κλινική εικόνα:

Δερματοσκοπική εικόνα:



Εικόνα 1 Ασθενής 1 α) κλινική εικόνα, β) δερματοσκοπική εικόνα: ινωτικό στάδιο – γαλακτώδης –κόκκινη περιοχή, τηλαγγειεκτασίες, μονήρεις τρίχες δίκην βούρτσας, γ) δερματοσκοπική εικόνα: ινωτικό στάδιο – λευκή περιοχή με ακανόνιστες λευκές τελείες, απουσία θυλακικών ανοιγμάτων.

Ιστολογική έκθεση:

Υλικό

Τμήμα δερματικής αλλοίωσης τριχωτού κεφαλής

Μακροσκοπικά

Το υλικό που στάλθηκε αποτελείται από ατρακτοειδές τμήμα δέρματος με διαστάσεις στην επιφάνεια 0,6Χ0,3 εκ. και πάχους έως 0,2 εκ.

Ιστοχημικός έλεγχος

Alcian blue, PAS

Μικροσκοπικά - Συμπέρασμα

Στην ιστολογική εξέταση παρατηρούνται, ήπιου έως μετρίου βαθμού, φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που συνίστανται σε μέτρια πυκνές χρόνιες φλεγμονώδεις διηθήσεις, λειχηνοειδώς κατανεμημένες, περιτριχοθυλακικά, στο χόριο. Παρατηρείται, περιοχικά, εστία ουλοποίησης σε έδαφος κατεστραμμένου τριχοθύλακου. Η επιδερμίδα, όπως και το λοιπό χόριο και υποδόριο λίπος, δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες παθολογικές αλλοιώσεις. Ο ιστοχημικός έλεγχος με τις ανωτέρω χρώσεις δεν ανέδειξε επιπλέον

αξιοσημείωτα παθολογικά ευρήματα. Μορφολογικά ευρήματα συμβατά με αυτά του τριχοθυλακικού λειχήνα.

Ασθενής 2:

Ασθενής, άρρεν, 41 ετών με α/α ρευματολογικό νόσημα, καπνιστής (30py) παρουσιάζει βλάβες σε άνω και κάτω άκρα υπερτροφικές, με ερύθημα και μέτριο προς σοβαρό κνησμό (7/10). Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με τοπικά κορτικοστεροειδή και παρουσιάζει σημαντική κλινική βελτίωση κατά την επανεκτίμηση (12/2024). Δεν είναι διαθέσιμες κλινικές και δερματοσκοπικές εικόνες κατά την διάγνωση.

Ιστολογική έκθεση:

Υλικό

Δερματική αλλοίωση

Μακροσκοπικά

Παρελήφθη ωοειδές τμήμα δέρματος διαστάσεων κατ'επιφάνεια 0,3X0,35 εκ. και πάχους χορίου-υποδορίου έως 0,3 εκ.

Μικροσκοπικά

Στην ιστολογική εξέταση του δερματικού ιστοτεμαχίου παρατηρείται κατά την επιδερμίδα συμπαγούς τύπου υπερκεράτωση και αλλοιώσεις υδρωπικής εκφύλισης της βασικής στοιβάδας. Στο χόριο παρατηρούνται σοβαρού βαθμού χρόνιες κυρίως φλεγμονώδεις διηθήσεις με λειχηνοειδή κατανομή.

Συμπέρασμα

Τα ως άνω περιγραφόμενα ευρήματα θα μπορούσαν να ενταχθούν στα πλαίσια της αναφερόμενης κλινικής διάγνωσης ομαλού λειχήνα.

Ασθενής 3

Ασθενής, θήλυ, 73 ετών κατά την ημέρα της επανεξέτασης στο τακτικό εξωτερικό δερματολογικό ιατρείο του ΠΑΓΝΗ με διεγνωσμένο κλινικά ομαλό λειχήνα από την ηλικία των 68 ετών. Η ασθενής κλινικά παρουσιάζει βλάβες σε άνω και κάτω άκρα με ήπιο συνοδό κνησμό 2/10. Αρχικά, η ασθενής αντιμετωπίστηκε με τοπικά κορτικοστεροειδή. Στη συνέχεια, λόγω μη ανταπόκρισης στην τοπική αγωγή, πραγματοποιήθηκε βιοψία, που επιβεβαίωσε την αρχική διάγνωση του ομαλού λειχήνα. Εν τέλει, η ασθενής ετέθη σε φωτοθεραπεία. Οι δερματοσκοπικές εικόνες ελήφθησαν μετά την έναρξη της φωτοθεραπείας.

Κλινική Εικόνα



Δερματοσκοπικές εικόνες



Εικόνα 2 Ασθενής 3: α) κλινική εικόνα, β) δερματοσκοπική εικόνα - μπλε-γκρι σφαιρίδια/ "peppering" (μαύρο βέλος) γ) δερματοσκοπική εικόνα - ροζέτες (μαύρο βέλος) και λαμπιρίζουσες λευκές γραμμές (μπλε βέλη)

Ιστολογική έκθεση:

Υλικό

Ιστοτεμάχιο δέρματος ΔΕ ποδοκνημική

Μακροσκοπικά

Παρελήφθη υποστρόγγυλο ιστοτεμάχιο μεγαλύτερας διαμέτρου 0,5 εκ.

Μικροσκοπικά - Συμπέρασμα

Το μακροσκοπικά περιγραφόμενο ιστοτεμάχιο παρουσιάζει ιστολογικά χαρακτηριστικά ομαλού λειχήνα.

Ασθενής 4:

Ασθενής, άρρεν, 52 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, εμφάνισε από τριετίας βλεννογονικές βλάβες με ήπιο συνοδό κνησμό (2/10) και διεγνώσθη με ομαλό λειχήνα μετά από παθολογοανατομική εξέταση. Ο ασθενής προσήλθε για επανεκτίμηση τον 12/2024, κατά την οποία ελήφθησαν οι παρακάτω κλινικές εικόνες, και παρουσιάζει σημαντική κλινική βελτίωση.

Κλινική εικόνα:



Εικόνα 3 Ασθενής 4 – Κλινική εικόνα: στοματικός βλεννογόνος κάτω χείλους με παρουσία καφέ μελαγχρωματικών βλαβών- σφαιριδίων .

Ιστολογική εξέταση:

Υλικό

Ακανόνιστη μελάγχρωση χειλέων από 12μηνου, βιοψία από μελαγχρωματική βλάβη βλεννογόνου κάτω χείλους.

Μακροσκοπικά

Παραλάβαμε ατρακτοειδές τμήμα δέρματος, διαστάσεων κατ' επιφάνεια 0,5 X 0,3 εκ. και πάχος χορίου-υποδορίου έως 0,2 εκ. Στην επιφάνεια αναγνωρίζεται καστανόφαιης χροιάς αλλοίωση, μεγίστης διαμέτρου 0,2 εκ. που φτάνει στο ένα εγχειρητικό όριο.

Μικροσκοπικά

Πολλαπλές εν τω βάθει τομές από το αποσταλέν τμήμα βλεννογόνου δείχνουν υπερπλασία του πολύστοιβου πλακώδους επιθηλίου, ήπια παρακεράτωση, έντονη σπογγίωση, και κατά θέσεις ακανθόλυση, παρουσία λίγων αποπτωτικών κερατινοκυττάρων. Αναγνωρίζεται, επίσης, αύξηση του αριθμού των βασικών δενδριτικών μελανοκυττάρων (MellanA+, S100+) και μελαγχρωματική ασυνέχεια, με την παρουσία πολυάριθμων

μελανινοφάγων στο θηλώδες χόριο (Masson-Fontana). Δεν παρατηρείται υπερμελάγχρωση των βασικών κερατινοκυττάρων στο παρόν υλικό. Αναγνωρίζεται, επίσης, ήπια εστιακή ατυπία, με την παρουσία λίγων μιτώσεων στο κατώτερο 1/3 του πάχους του καλυπτικού επιθηλίου, πιθανώς αναγεννητικής αιτιολογίας. Στο υποκείμενο θηλώδες χόριο παρατηρούνται μετρίου βαθμού φλεγμονώδεις διηθήσεις χρονίου τύπου, με λειχηνοειδή κατανομή, διάχυτα και ελάχιστες περιαγγειακά (CD3+ λεμφοκύτταρα), μεταξύ των οποίων και άφθονα πλασματοκύτταρα, που επινέμονται το καλυπτικό επιθήλιο.

Συμπέρασμα

Τμήμα βλεννογόνου με λειχηνοειδώς κατανεμημένες φλεγμονώδεις διηθήσεις χρονίου τύπου, αύξηση μελανοκυττάρων και μελαγχρωματική ασυμμετρία. Τα ως άνω περιγραφέντα ανοσομορφολογικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να ενταχθούν στα πλαίσια μελανοκυτταρικής μετανάστευσης σχετιζόμενης με φλεγμονή ή τραύμα.

Ασθενής 5:

Ασθενής, θήλυ, 53 ετών με α/α ψωρίαση, καπνίστρια (30 py) παρουσίασε σε ηλικία 43 ετών ιωδεις στίλβουσες βλατίδες σε κορμό, άνω και κάτω άκρα με συνοδό σοβαρό κνησμό (10/10) συμβατές με υπερτροφικό ομαλό λειχήνα. Η ασθενής κατά την επανεκτίμησή της (12/2024) αναφέρει ότι μετά από θεραπεία με βιολογικό παράγοντα που έλαβε για την ψωρίαση σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή παρουσιάζει πλήρη ύφεση των βλαβών. Δεν είναι διαθέσιμες κλινικές και δερματοσκοπικές εικόνες από την διάγνωση.

Ιστολογική εξέταση:

Υλικό

Βιοψία από οσφύ.

Μακροσκοπικά

Παραλάβαμε ατρακτοειδές τμήμα δέρματος, διαστάσεων κατ'επιφάνεια 0,7 X 0,4 εκ. και πάχους χορίου - υποδορίου 0,5 εκ.

Μικροσκοπικά - Συμπέρασμα

Κατά τη μικροσκοπική εξέταση του αποσταλέντος τμήματος δέρματος, και αντίστοιχα προς την επιδερμίδα, παρατηρούνται θέσεις υπερκεράτωσης, συμπαγούς κυρίως τύπου, υπερκοκκίωσης σφηνοειδούς τύπου, ανομοιόμορφη ακάνθωση, ήπια σπογγίωση, καθώς και υδρωπική εκφύλιση

της βασικής στοιβάδας, με κατά θέσεις αποκόλληση της επιδερμίδας από το υποκείμενο χόριο. Αναγνωρίζονται, επίσης, αποπτωτικά κερατινοκύτταρα και κυτταροειδή σωμάτια. Στο χόριο αναγνωρίζονται μετρίου βαθμού, ζωνοειδώς κυρίως κατανεμημένες, καθώς και περιαγγειακές-περιεξαρτηματικές, λεμφοϊστοκυτταρικές αθροίσεις, μεταξύ των οποίων και αρκετά μελανινοφάγα, οι οποίες κατά θέσεις επινέμονται το καλυπτικό επιθήλιο. Ο ιστοχημικός έλεγχος με τη χρώση PAS δεν ανέδειξε την παρουσία υφών/σπορίων μυκήτων ή άλλων μικροοργανισμών. Μορφολογικοί χαρακτήρες λειχηνοειδούς δερματίτιδας, συμβατοί ομαλού λειχήνα που τέθηκε στην κλινική διαφορική διάγνωση.

Ασθενής 6:

Ασθενής, θήλυ, 22 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό (α/α), μη καπνίστρια, παρουσίασε βλάβες σε κορμό, άνω και κάτω άκρα με στοιχεία υπερτροφίας και συνοδό σοβαρό κνησμό (9/10) συμβατές με ομαλό λειχήνα. Πραγματοποιήθηκε βιοψία από ερυθρηματώδη πλάκα του αριστερού μηρού, η οποία συνηγορεί υπέρ της διάγνωσης του ομαλού λειχήνα. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με τοπικά κορτικοστεροειδή και συμπτωματική θεραπεία για τον κνησμό με αντισταμινικά για 20 ημέρες και κατά την επανεκτίμηση μετά από 3 μήνες δεν παρουσίαζε πλέον καμία βλάβη. Στα πλαίσια της εργασίας έγινε και τηλεφωνικό follow up τον 12/2024 στους εννέα (9) μήνες από την διάγνωση και η ασθενής αναφέρει ελεύθερη νόσου χωρίς βλάβες από τον 6/2024 και άνευ αγωγής. Όπως έχει περιγραφεί ο ομαλός λειχήνας είναι αυτοπεριοριζόμενος στους 6 μήνες – 2 έτη.

Δερματοσκοπικές εικόνες κατά τη διάγνωση δεν είναι διαθέσιμες, ενώ κατά την επανεκτίμηση στους 3 μήνες η ασθενής δεν παρουσίαζε κάποια βλάβη.

Ιστολογική εξέταση:

Υλικό

Ερυθρηματώδης πλάκα αριστερού μηρού

Μακροσκοπικά

Παρελήφθη ατρακτοειδές τμήμα δέρματος διαστάσεων κατ'επιφάνεια 0,7 X 0,35 εκ. και πάχους χορίου-υποδορίου έως 0,2 εκ.

Μικροσκοπικά - Συμπέρασμα

Αντίστοιχα προς το αποσταλέν τμήμα δέρματος παρατηρούνται ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά χρόνιας δερματίτιδας της δερμοεπιδερμικής

συμβολής με λειχηνοειδή χαρακτηριστικά συμβατά της κλινικής διαφορικής διάγνωσης του ομαλού λειχήνα.

Ασθενής 7:

Ασθενής, άρρεν, 60 ετών με α/α καπνιστής (30 py) εμφάνισε προ τετραετίας ερυθματολεπιδώδεις κνησμώδεις (10/10) πλάκες σε άνω και κάτω άκρα, συμβατές με υπερτροφικό ομαλό λειχήνα. Ο ασθενής κατά την επανεκτίμησή του (12/2024) αναφέρει πλήρη ίαση μετά από θεραπεία με τοπικά κορτικοστεροειδή. Κλινικές και δερματοσκοπικές εικόνες από την διάγνωση δεν είναι διαθέσιμες.

Ιστολογική εξέταση:

Υλικό

Βιοψία ερυθματώδους πλάκας δέρματος αριστερής κνήμης

Μακροσκοπικά

Παρελήφθη ατρακτοειδές τμήμα δέρματος διαστάσεων κατ' επιφάνεια 1 X 0,4 εκ. και πάχους χορίου έως 0,2 εκ.

Μικροσκοπικά

Σε πολλαπλές εξετασθείσες εν σειρά τομές του αποσταλέντος τμήματος δέρματος, αντίστοιχα προς την επιδερμίδα παρατηρούνται ήπια υπερκεράτωση συμπαγούς τύπου, θέση παρακεράτωσης που περιλαμβάνει άθροιση ουδετεροφίλων πολυμορφοπυρήνων λευκοκυττάρων, ήπια ανομοιόμορφη ακάνθωση, περιοχές υδρωπικής εκφύλισης της βασικής στοιβάδας που εκτείνονται και στο εξωτερικό επιθηλιακό έλυτρο τριχοθυλάκων, καθώς και εστίες ήπιας επινέμησης από μικρά λεμφοκύτταρα. Το ανώτερο δερματικό χόριο παρουσιάζει ίνωση, εξαγγειωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια, πυκνές περιανγειακές φλεγμονώδεις διηθήσεις χρονίου τύπου, οι οποίες κατά θέσεις συρρέουν λειχηνοειδώς παράλληλα της επιδερμίδας ασαφопоιώντας τη δερμοεπιδερμидική συμβολή και εστιακά συμπεριλαμβάνουν και μικρό αριθμό ηωσινοφίλων λευκοκυττάρων. Τα τελευταία, κατά θέσεις διαμορφώνουν μικρές αθροίσεις, εστιακά διατάσσονται διαχύτως στο στρώμα και αρκετά από αυτά είναι σε φάση αποκοκκίωσης.

Συμπέρασμα

Τμήμα δέρματος με αλλοιώσεις χρόνιας δερματίτιδας της δερμοεπιδερμидικής συμβολής, λειχηνοειδούς τύπου και επιμέρους χαρακτηριστικά που εγείρουν την υπόνοια φαρμακευτικής αντίδρασης.

Ασθενής 8:

Ασθενής, άρρεν, 76 ετών, με α/α ελεύθερο παρουσιάζει βλάβες σε κορμό με συνοδό μέτριο κνησμό (6/10), συμβατές με κλασσικό ομαλό λειχήνα. Ο ασθενής κατά την επανεκτίμηση (12/2024) αναφέρει πλήρη ίαση μετά από θεραπεία με τοπικά κορτικοστεροειδή.

Ιστολογική εξέταση:

Υλικό

Βιοψία δερματικής αλλοίωσης οσφυϊκής χώρας

Μακροσκοπικά

Παρελήφθη ατρακτοειδές τμήμα δέρματος διαστάσεων κατ' επιφάνεια 1,2 X 0,4 εκ. και πάχους χορίου έως 0,3 εκ.

Μικροσκοπικά - Συμπέρασμα

Το αποσταλέν τμήμα δέρματος παρουσιάζει αλλοιώσεις δερματίτιδας της δερμοεπιδερμидικής συμβολής με ιστολογικά χαρακτηριστικά συμβατά της κλινικής διαφορικής διάγνωσης του λειχήνα.

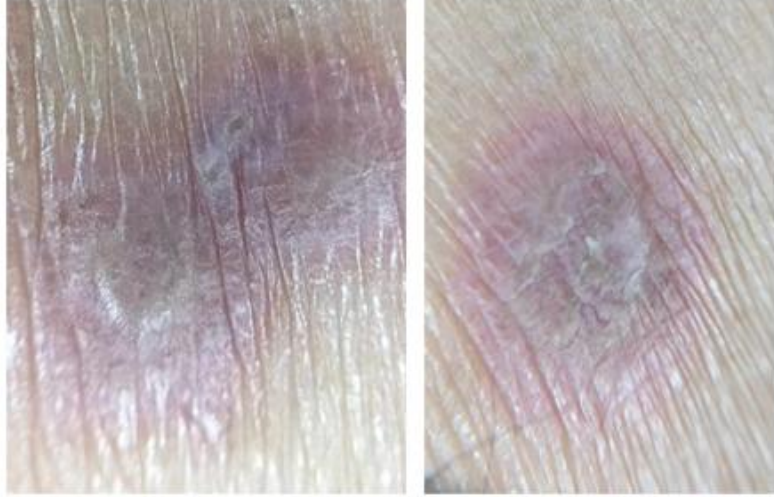
Ασθενής 9:

Ασθενής, άρρεν, 78 ετών με α/α Ca πνεύμονα -μη χειρουργήσιμο, υπό Ανοσοθεραπεία (pembrolizumab anti-PD1, 4 κύκλοι) και ΧΜΘ (6 κύκλοι- διακοπή λόγω αναιμίας), ΣΔ τύπου II (υπό μετφορμίνη και ινσουλίνη μακράς διάρκειας δράσης), πρώην καπνιστής με 30 pack per year (py). παρουσιάζει βλάβες σε κορμό, άνω και κάτω άκρα με συνοδό σοβαρό κνησμό (9/10). Ο ασθενής Προσήλθε στα ΤΕΙ δερματοχειρουργικής για εκτίμηση εξανθήματος από 15ημέρου. Το εξάνθημα ήταν λειχηνοειδές, ιώδες με παρουσία πλακών με κατά τόπους βλατίδες, στίλβον (+/-), με συνοδό σοβαρό κνησμό (9/10) και με εντόπιση σε άνω, κάτω άκρα και κορμό. Αναφέρεται έκθυση του εξανθήματος μετά τον δεύτερο κύκλο ανοσοθεραπείας. Πραγματοποιήθηκε βιοψία δέρματος από βλάβη αριστερής κνήμης με διαφοροδιάγνωση ομαλός λειχήνας, λειχηνοειδής φαρμακευτική αντίδραση ή ψωρίαση.

Κλινική εικόνα



Δερματοσκοπικές εικόνες



Εικόνα 4 Ασθενής 9: α) κλινική εικόνα β,γ) δερματοσκοπικές εικόνες – φόντο ροζ με λευκές λαμπιρίζουσες γραμμές.

Ιστολογική εξέταση:

Υλικό

Βιοψία δερματικής βλάβης αριστερής κνήμης.

Μακροσκοπικά

Παραλάβαμε ατρακτοειδές τμήμα δέρματος, διαστάσεων κατ'επιφάνεια 1 Χ 0,7 εκ. και πάχους χορίου - υποδορίου έως 0,1 εκ. Στην επιφάνεια αναγνωρίστηκε ελαφρώς επηρμένη, λευκόφαιης χροιάς βλάβη, μεγίστης διαμέτρου 1 εκ.

Μικροσκοπικά

Κατά τη μικροσκοπική εξέταση του αποσταλέντος τμήματος δέρματος, και αντίστοιχα προς την επιδερμίδα, παρατηρείται ανομοιόμορφη ακάνθωση, υπερκεράτωση συμπαγούς τύπου, υδρωπική εκφύλιση της βασικής στοιβάδας, αποκόλληση της επιδερμίδας στο επίπεδο της δερμοεπιδερμидικής συμβολής, και αποπτωτικά κερατινοκύτταρα. Στο χόριο αναγνωρίζονται λίγα κυτταροειδή σωμάτια, μέτριου βαθμού, ζωνοειδώς κυρίως κατανεμημένες, καθώς και περιαγγειακές-περιεξαρτηματικές, λεμφοϊστιοκυτταρικές αθροίσεις, μεταξύ των οποίων μελανινοφάγα, καθώς και ήπια εστιακή εξαγγείωση ερυθρών. Τα φλεγμονώδη στοιχεία επινέμονται κατά θέσεις την επιδερμίδα.

Αναγνωρίζεται οίδημα των ενδοθηλιακών κυττάρων, χωρίς ευρήματα αγγειΐτιδας. Ο ιστοχημικός έλεγχος με τις χρώσεις PAS απέβη αρνητικός. Ηωσινόφιλα λευκοκύτταρα δεν παρατηρούνται στις πολλαπλές εν τω βάθει εξετασθείσες τομές.

Συμπέρασμα

Μορφολογικοί χαρακτήρες λειχηνοειδούς δερματίτιδας συμβατοί ομαλού λειχήνα, που τέθηκε στην κλινική διαφορική διάγνωση.

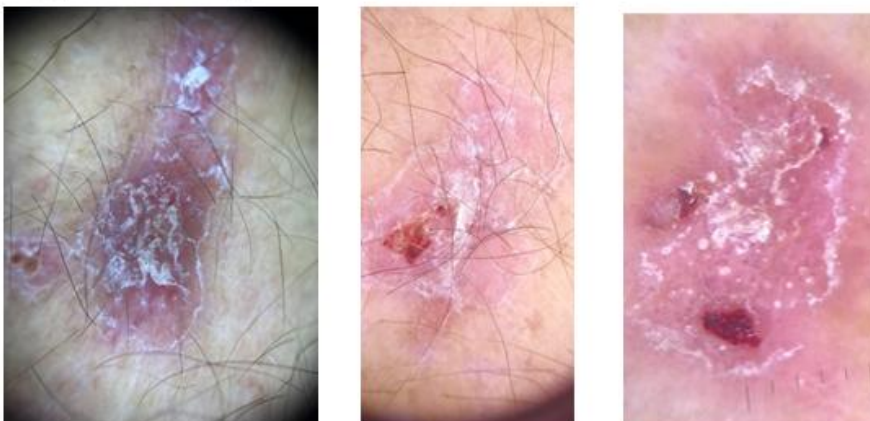
Ασθενής 10:

Πρόκειται για ασθενή, άρρεν, 62 ετών με α/α N. Crohn, κάπνισμα. Ο ασθενής παρουσίασε βλάβες σε κορμό, άνω, κάτω άκρα, καθώς και στον στοματικό βλεννογόνο και συγκεκριμένα στα κάτω χείλη. Οι δερματοσκοπικές εικόνες ελήφθησαν στην πρώτη επίσκεψη, πριν την έναρξη θεραπείας. Ελήφθη βιοψία βλεννογόνου κάτω χείλους. Ο ασθενής δυστυχώς απεβίωσε τον 06/2024 νοσηλευόμενος στη γαστρεντερολογική κλινική.

Κλινική εικόνα



Δερματοσκοπική εικόνα



Εικόνα 5 Ασθενής 10: α,β) κλινική εικόνα, γ,δ,ε) δερματοσκοπική εικόνα - δίκτυο Wickham

Ιστολογική εξέταση:

Υλικό

Βιοψία αλλοίωσης βλεννογόνου κάτω χείλους

Μακροσκοπικά

Παραλάβαμε λευκόφαιο ιστοτεμάχιο μεγίστης διαμέτρου 0,4 εκ.

Μικροσκοπικά

Αναγνωρίζεται ινώδης και ώριμος λιπώδης ιστός χωρίς επιθηλιακή επικάλυψη που εμφανίζει ανάπτυξη χρόνιου κοκκιώδους φλεγμονώδους ιστού με παρουσία σπάνιων ηωσινοφίλων.

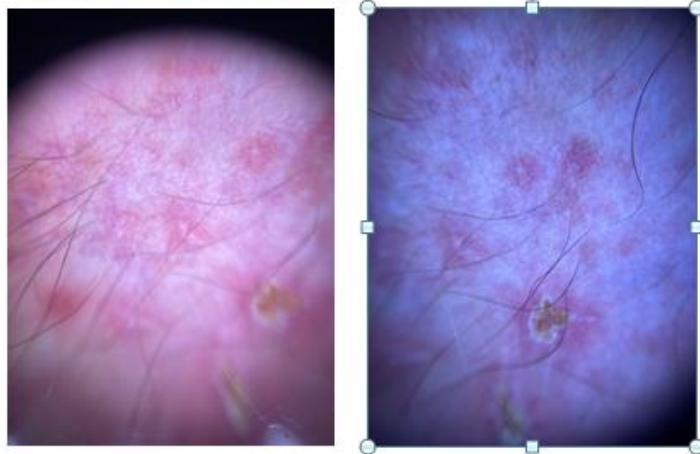
Ασθενής 11:

Ασθενής, άρρεν, 71 ετών με α/α καπνιστής (20 py), παρουσιάζει πομφολυγώδες κνησμώδες (9/10) εξάνθημα σε άνω άκρα. Κατά την διερεύνηση πραγματοποιήθηκε παθολογοανατομική εξέταση, άμεσος ανοσοφθορισμός και ποσοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων anti-BP180, anti-BP230 με Elisa. Κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς στο τμήμα ελήφθησαν οι κλινικές και δερματοσκοπικές εικόνες, πριν την έναρξη θεραπείας.

Κλινική εικόνα



Δερματοσκοπική εικόνα



Εικόνα 6 Ασθενής 11: α) κλινική εικόνα β,γ) δερματοσκοπική εικόνα - γραμμικά αγγεία με ομοιόμορφη κατανομή, λαμπιρίζουσες λευκές γραμμές σε ροζ υπόβαθρο.

Ιστολογική εξέταση:

Υλικό

Δερματική αλλοίωση

Μακροσκοπικά

Παραλάβαμε ατρακτοειδές τμήμα δέρματος διαστάσεων κατ'επιφάνεια 1,4Χ0,6 εκ. και πάχους χορίου - υποδορίου 0,3 εκ. Στην επιφάνεια αναγνωρίστηκε λευκόφαιη επίπεδη αλλοίωση μεγίστης διαμέτρου 0,3 εκ.

Μικροσκοπικά

Στην ιστολογική εξέταση του δερματικού ιστοτεμαχίου, παρατηρείται κατά την επιδερμίδα υπερκεράτωση με εστιακή παρακεράτωση, επιμήκυνση των θηλωδών καταδύσεων και αλλοιώσεις υδρωπικής εκφύλισης της βασικής στοιβάδας. Το χόριο εμφανίζει θέσεις με οίδημα και μέτρια πυκνές χρόνιες φλεγμονώδεις διηθήσεις με συμμετοχή και ηωσινοφίλων. Οι φλεγμονώδεις διηθήσεις εμφανίζουν λειχηνοειδή και περιαγγειακή κατανομή.

Συμπέρασμα

Τα ως άνω περιγραφόμενα ευρήματα είναι περισσότερο συμβατά με λειχηνοειδή δερματίτιδα, τύπου ομαλού λειχήνα.

Άμεσος Ανοσοφθορισμός: εικόνα ανοσοφθορισμού θετική για IgG

Έμμεσος Ανοσοφθορισμός: εικόνα ανοσοφθορισμού θετική για IgG

Ποσοτικός προσδιορισμός – Elisa:

Anti-BP180 (+) 103

Anti-BP230 (+) 43

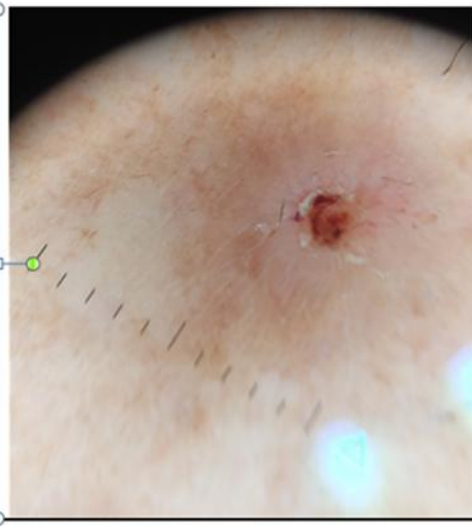
Ασθενής 12:

Ασθενής, θήλυ, 63 ετών με α/α ελεύθερο παρουσιάζει ήπια κνησμώδεις βλάβες (6/10) σε κορμό, άνω και κάτω άκρα συμβατές με κλασσικό ομαλό λειχήνα. Η ασθενής κατά την επανεκτίμησή της (12/2024) αναφέρει ότι πλέον παρουσιάζει περιστασιακά βλάβες σε κάτω άκρα, τις οποίες αντιμετωπίζει με τοπικά κορτικοστεροειδή. Συγκεκριμένα κατά την επανεκτίμηση η ασθενής είχε μια νέα βλάβη στη πρόσθια επιφάνεια την ΔΕ κνήμης και ελήφθησαν κλινικές και δερματοσκοπικές φωτογραφίες.

Κλινική εικόνα:



Δερματοσκοπική εικόνα:



Εικόνα 7 Ασθενής 12 α) Κλινική εικόνα β) δερματοσκοπική εικόνα: δίκτυο Wickham

Ιστολογική εξέταση:

Υλικό

10646: Ιστοτεμάχιο δέρματος από δεξιό στήρνο, 10647: Ιστοτεμάχιο δέρματος από αριστερή

κνήμη

Μακροσκοπικά

10646: Παρελήφθη ατρακτοειδές τμήμα δέρματος διαστάσεων κατ'επιφάνεια 0,7X0,3 εκ. και πάχους χορίου-υποδορίου έως 0,2 εκ. Στην επιφάνεια αναγνωρίστηκε λευκόφαιης χροιάς επίπεδη βλάβη μεγαλύτερας διαμέτρου 0,4 εκ.

10647: Παρελήφθη ατρακτοειδές τμήμα δέρματος διαστάσεων κατ'επιφάνεια 0,7X0,3 εκ. και πάχους χορίου-υποδορίου έως 0,1 εκ. Στην επιφάνεια αναγνωρίστηκε λευκόφαιης χροιάς επίπεδη βλάβη μεγαλύτερας διαμέτρου 0,5 εκ.

Μικροσκοπικά - Συμπέρασμα

10646: Αντίστοιχα προς την αλλοίωση που περιγράφεται μακροσκοπικά παρατηρούνται δυσπλαστικές αλλοιώσεις της επιδερμίδας ως επί ακτινικής κεράτωσης.

10647: Στην ιστολογική εξέταση του δερματικού ιστοτεμαχίου παρατηρείται κατά την επιδερμίδα, συμπαγούς τύπου υπερκεράτωση, επιμήκυνση των θηλωδών καταδύσεων και θέσεις με υδρωπική εκφύλιση της βασικής

στοιβάδας. Το χόριο εμφανίζει μέτρια πυκνές φλεγμονώδεις διηθήσεις από στοιχεία χρόνιας φλεγμονής με συμμετοχή και σπάνιων ηωσινοφίλων. Τα φλεγμονώδη στοιχεία έχουν περιαγγειακή και λειχηνοειδή κατανομή και κατά θέσεις επινέμονται την υπερκείμενη επιδερμίδα. Τα ως άνω περιγραφόμενα ευρήματα θα μπορούσαν να απαντηθούν στα πλαίσια της αναφερόμενης κλινικής διάγνωσης ομαλού λειχήνα.

Πίνακας 10. Επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών της μελέτης

Ασθενής	ΗΛΙΚΙΑ	ΦΥΛΟ	ΕΝΤΟΠΙΣΗ	ΜΟΡΦΗ ΟΛ	ΚΝΗΣΜΟΣ (0-10)	Α/Α
1	56	ΘΗΛΥ	ΤΡΙΧΩΤΟ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΒΛ.	ΘΥΛΑΚΙΚΟΣ	2	Υποθυρεοειδισμός, ΙΦΝΕ, Κάπνισμα (stop 20py)
2	41	ΑΡΡΕΝ	ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ	ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΣ	7	Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Κάπνισμα 30py
3	68	ΘΗΛΥ	ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ	ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ	9	Κάπνισμα (stop 10py)
4	49	ΑΡΡΕΝ	ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΒΛ.	ΒΛΕΝΝΟΡΙΝΙΚΟΣ	2	Κάπνισμα (20py)
5	43	ΘΗΛΥ	ΚΟΡΜΟ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ	ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΣ	10	ΨΩΡΙΑΣΗ, κάπνισμα (30py)
6	22	ΘΗΛΥ	ΚΟΡΜΟ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ	ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ	9	Ελεύθερο
7	56	ΑΡΡΕΝ	ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ	ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΣ	10	Κάπνισμα (30py)
8	76	ΑΡΡΕΝ	ΚΟΡΜΟ	ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ	6	Ελεύθερο
9	78	ΑΡΡΕΝ	ΚΟΡΜΟ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ	ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ	9	Ca πνεύμονα- ΧΜΘ Κάπνισμα (stop 30py) ΣΔ πII
10	62	ΑΡΡΕΝ	ΚΟΡΜΟ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ	ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ	6	Νόσος Crohn, Κάπνισμα, ΘΑΝΑΤΟΣ
11	71	ΑΡΡΕΝ	ΑΝΩ ΑΚΡΑ	ΠΕΜΦΙΓΟΙΔΗΣ	9	Κάπνισμα (20 py)
12	63	ΘΗΛΥ	ΚΟΡΜΟ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ	ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ	6	ελεύθερο

Πίνακας 11. Φύλο και μορφές ΟΛ με ποσοστά ασθενών της μελέτης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Φύλο:		
Αρρεν	7	58%
Θηλυ	5	42%
Μορφές ΟΛ:		
Α) Κλασσικός	6	50%
Β) Υπερτροφικός	3	25%
Γ) Θυλακικός	1	8%
Δ) Στοματικού βλ.	1	8%
Ε) Πεμφιγοειδής	1	8%

Πίνακας 12. Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά ασθενών της μελέτης												
ΑΣΘΕΝΗΣ/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Δερματοσκοπικά Χαρακτηριστικά :												
Αγγειακό Πρότυπο:												
A) Σπινμοειδή/ "dotted"												
B) Γραμμικά/ "linear"											+	
Κατανομή Αγγείων:												
A) Ομοιόμορφη											+	
B) Περιφερική												
Γ) Μη ειδική												
Ειδικά ευρήματα:												
Δίκτυο Wickham										+		+
Φανεσωροειδή ανοίγματα												
Άλλες δομές:												
II) Λευκές λαμπριζουσες δομές:												
A) ροζέτες			+									
B) λαμπριζουσες λευκές δομές	+		+						+		+	
Γ) λαμπριζουσες λευκές χωρίς δομή περιοχές			+									
Δ) πολύχρωμο πρότυπο									+			
II) Μπλε- γκρι τελείες/σφαιρίδια/perpeting			+	+					+			
III) Χωρίς δομή περιοχές με υπόβαθρο χρώματος:												
A) ροζ/ροζ-καφέ/ροζ-γκρι									+	+	+	+
B) Γκρι/Μπλε-γκρι			+									
Γ) καφέ-γκρι/καφέ												

Πίνακας 13. Παθολογοανατομικά ευρήματα στους ασθενείς της μελέτης

ΑΣΘΕΝΗΣ/ Ιστολογικά ευρήματα:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Υπερκεράτωση συμπαγούς τύπου		+			+		+		+		+	+
Παρακεράτωση				+			+				+	
Σπογγίωση				++	+							
Ακάνθωση					+		+		+			
Υπερκοκκίωση					+							
Ακανθόλυση				+								
Υδρωπική εκφύλιση βασικής στιβάδας		+			+		+		+		+	+
Κυτταροειδή σωματίδια στο χόριο					+				+			
Παρουσία μελανινοφάγων στο χόριο				+	+				+			
Μελανινοκυτταρική μετανάστευση				+								
Επιμήκυνση θηλωδών καταδύσεων											+	+
Φλεγμονώδεις διηθήσεις λειχηνοειδούς κατανομής/ λειχηνοειδής δερματίτιδα	+	+		+	+	+	+	+	+		+	+
Ουλοποίηση	+											
Ίνωση							+					

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Περιγράφουμε τα κυρίαρχα δερματοσκοπικά ευρήματα του ομαλού λειχήνα στις διάφορες κλινικές μορφές του και τονίζουμε τον σημαντικό ρόλο της δερματοσκόπησης, τόσο στη διάγνωση όσο και στη παρακολούθηση των ασθενών με αυτή τη φλεγμονώδη δερματοπάθεια.

Όπως είναι γνωστό ο ΟΛ είναι μια αυτοπεριοριζόμενη νόσος, με μέση διάρκεια 1-2 έτη. Συνήθως σε πάνω από το 50% των ασθενών η νόσος αυτοπεριορίζεται εντός 6 μηνών από την εμφάνιση (13,14), όπως συνέβη στην ασθενή 6 της παρούσας μελέτης. Επίσης 5 από τους 12 ασθενείς παρουσιάζουν ύφεση νόσου, χωρίς ενεργές βλάβες κατά την επανεκτίμησή τους.

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών του ΟΛ, το πιο συχνό δερματοσκοπικό εύρημα είναι το δίκτυο του Wickham (Wickham Striae, WS), που θεωρείται παθογνωμονικό και συμβάλει σημαντικά στη διαφορική διάγνωση, ωστόσο η απουσία αυτού δεν αποκλείει την διάγνωση. Το WS έχει συσχετιστεί με ενεργές βλάβες ομαλού λειχήνα και μπορεί να εμφανιστεί ως λευκές δικτυωτές ή δαντελοειδείς δομές (15), όπως παρατηρήσαμε στον ασθενή 10 σε μόλις διαγνωσθέν ομαλό λειχήνα με τη μορφή δαντέλας στην περιφέρεια της βλάβης. Καθώς επίσης στην ασθενή 12 σε νεοεμφανισθείσα βλάβη, που απεικονίστηκε κατά την επανεκτίμηση της ασθενούς, παρατηρούμε δίκτυο Wickham. Δεν είναι όμως το μοναδικό δερματοσκοπικό εύρημα και καθώς ο ομολός λειχήνας παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις με διαφορετική κλινική και δερματοσκοπική εικόνα. Για αυτό τον λόγο θεωρούμε ότι η περαιτέρω έρευνα στον τομέα της δερματοσκόπησης έχει να προσφέρει πολλά και να μειώσει στο μέλλον ακόμα περισσότερο τις βιοψίες, που πραγματοποιούνται σε περιστατικά με άτυπη κλινική και δερματοσκοπική εικόνα ΟΛ.

Επίσης όπως αναφέρθηκε παραπάνω η δερματοσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέθοδος παρακολούθησης και πρόγνωσης για την έκβαση μιας θεραπείας. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία συνήθως το δίκτυο Wickham παρατηρείται σε ενεργές βλάβες, ενώ μετά από θεραπεία μπορεί να απουσιάζει (96). Έτσι και στην παρούσα μελέτη παρατηρείται ότι από τους 7 ασθενείς, από τους οποίους διαθέτουμε κλινικές και δερματοσκοπικές εικόνες,

οι δύο παρουσιάζουν δίκτυο Wickham σε νεοεμφανισθείσες βλάβες και σε βλάβες που δεν έχει τεθεί ακόμα κάποιου είδους θεραπεία. Ενώ στους υπόλοιπους 5 ασθενείς, οι οποίοι είχαν τεθεί σε θεραπεία κατά την ημέρα της επανεξέτασης, δεν παρατηρείται δίκτυο Wickham. Αντίθετα τα μελαγχρωματικά πρότυπα φαίνεται να παραμένουν ή να εμφανίζονται σε προχωρημένα στάδια παρά τις θεραπείες (96). Στην παρούσα μελέτη παρατηρούμε ότι στην ασθενή 3, μετά από θεραπεία, δεν παρατηρείται WS αν και παρατηρούνται άλλες λαμπιρίζουσες λευκές δομές, όπως οι ροζέτες. Ακόμη στην ίδια ασθενή, η οποία διεγνώσθη προ πενταετίας και παρουσιάζει εμμένουσα κλινική εικόνα παρά τις θεραπείες, παρατηρούνται μελαγχρωματικά πρότυπα, όπως μπλε σφαιρίδια, που υποδηλώνουν το προχωρημένο στάδιο της νόσου.

Στη παρούσα μελέτη έγινε επίσης προσπάθεια να παρουσιαστούν τα κύρια παθολογοανατομικά ευρήματα (Πίνακας 13) στη σειρά ασθενών μας και να γίνει συσχέτιση με τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά που ανευρέθηκαν κατά την δερματοσκόπηση. Σύμφωνα με τη μελέτη των Awatef Kelati και συνεργατών, η οποία δημοσιεύθηκε το 2024, το δίκτυο Wickham αντιστοιχεί παθολογοανατομικά με υπερκοκκίωση και ακάνθωση μαζί. Τα μπλε-γκρι σφαιρίδια σχετίζονται με ακράτεια μελανίνης, ενώ οι λευκές γραμμές με ορθοκεράτωση. Οι λαμπιρίζουσες λευκές γραμμές αντιστοιχούν σε ίνωση στο χόριο και οι αγγειακές δομές στα αγγεία του χορίου.

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τον σπουδαίο ρόλο της δερματοσκόπησης τόσο στη διάγνωση του ομαλού λειχήνα όσο και στην παρακολούθηση των ασθενών. Καθώς επίσης επισημαίνεται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα με σκοπό την πιθανή ανεύρεση και άλλων ειδικών δερματοσκοπικών ευρημάτων και την μελέτη της συσχέτισης των δερματοσκοπικών αυτών ευρημάτων με την πρόγνωση της νόσου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Wilson E. On leichen planus. J Cutan Med Dis Skin 1869; 3: 117–32.
2. Boyd AS, Neldner KH. Lichen planus. J Am Acad Dermatol 1991;25:593-619.
3. Wagner G, Rose C, Sachse MM. Clinical variants of lichen planus. J Dtsch Dermatol Ges. 2013;11(4):309–19. doi: 10.1111/ddg.12031. [DOI] [PubMed]
4. Lehman JS, Tollefson MM, Gibson LE. Lichen planus. Int J Dermatol. 2009;48(7):682–94. doi: 10.1111/j.1365-4632.2009.04062.x. [DOI] [PubMed]
5. Al-Mutairi N, El-Khalawany M. Clinicopathological characteristics of lichen planus pigmentosus and its response to tacrolimus ointment: an open label, non-randomized, prospective study. JEur Acad Dermatol Venereol 2010; 24: 535–540.
6. Goldstein BG, Goldstein AO, Mostow E. (2019). Lichen planus, UpToDate. 2019: Post WT (eds), published by UpToDate in Waltham, MA.
7. Gupta S, Jawanda MK. Oral Lichen Planus: An Update on Etiology, Pathogenesis, Clinical Presentation, Diagnosis and Management. Indian J Dermatol. 2015;60(3):222-229. DOI:10.4103/0019-5154.156315. PMID: 26120146. PMCID: PMC4458931.
8. Wagner G, Rose C, Sachse MM. Clinical variants of lichen planus. J Dtsch Dermatol Ges. 2013;11(4):309-319. DOI:10.1111/ddg.12031. PMID: 23320493.
9. Güngör Ş, Topal IO, Göncü EK. Dermoscopic patterns in active and regressive lichen planus and lichen planus variants: a morphological study. Dermatol Pract Concept. 2015;5(2):45-53. DOI: 10.5826/dpc.0502a06. PMID: 26114051. PMCID: PMC4462898.
10. Agata Szykut-Badaczewska, Mariusz Sikora , Lidia Rudnicka, et al. Dermatoscopy of Cutaneous Lichen Planus - Attempt to Translate Metaphoric Terminology Into Descriptive Terminology. Dermatol Pract Concept. 2023 Jul 1;13(3):e2023174. doi: 10.5826/dpc.1303a174.
11. Agata Szykut-Badaczewska, Mariusz Sikora, Lidia Rudnicka, et al. Dermatoscopy of Cutaneous Lichen Planus – Attempt to Translate Metaphoric Terminology Into Descriptive Terminology. Dermatol Pract Concept. 2023;13(3):e2023174. DOI: <https://doi.org/10.5826/dpc.1303a174>

12. Jain S et al. Direct Immunofluorescence Studies in Lichen Planus. Turk Patoloji Derg. (2019) 35:193-7
13. Ioannides D et al. European S1 guidelines on the management of lichen planus: a cooperation of the European Dermatology Forum with the European Academy of Dermatology and Venereology. J Eur Acad Dermatol Venereol. (2020) 34 :1403-14
14. Irvine C et al. Long-term follow-up of lichen planus. Acta Derm Venereol. (1991) 71:242-4
15. Boch K et al. Lichen Planus. Front Med (2021) 1:8:737813
16. Mignogna MD et al. Oral lichen planus: different clinical features in HCV-positive and HCV-negative patients. Int J Dermatol. (2000) 39 : 134-9
17. Boch K. et al. Retrospective analysis of the clinical characteristics and patient-reported outcomes in vulval lichen planus: results from a single-center study. J Dermatol. (2021). 48:1913-1917
18. Atzmony L, Reiter O, Hodak E, et al. Treatments for Cutaneous Lichen Planus: A Systematic Review and MetaAnalysis. Am J Clin Dermatol 2016;17:11-22.
19. Robles-Méndez JC, Rizo-Frías P, Herz-Ruelas ME, Pandya AG, Ocampo Candiani J. Lichen planus pigmentosus and its variants: review and update. Int J Dermatol. 2018;57(5):505-514. DOI: 10.1111/ijd.13806. PMID: 29076159.
20. Giuliani M et al. Rate of malignant transformation of oral lichen planus: A systematic review. Oral Dis (2019). 25:693-709
21. Friedl TK et al. Verrucous squamous cell carcinoma complicating hypertrophic lichen planus. Three case reports and review of the literature. Hautarzt (2011) 62:40-45
22. Usatine RP, Tinitigan M. Diagnosis and treatment of lichen planus. Am Fam Physician 2011;84(1):53-60. PMID: 21766756
23. Papageorgiou C, Apalla Z, Lazaridou E, et al. Atypical case of lichen planus recognized by dermoscopy. Dermatol Pract Concept 2016;6:39-42.
24. Russo T, Piccolo V, Lallas A, Argenziano G. Recent advances in dermoscopy. F1000Res. 2016;5. doi: 10.12688/f1000research.7597.1. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
25. Argenziano G et al. Dermoscopy of pigmented skin lesions: results of a consensus meeting via the internet. J Am Acad Dermatol (2003) 48:679-93

26. Lallas A, Kyrgidis A, Tzellos TG, et al. Accuracy of dermoscopic criteria for the diagnosis of psoriasis, dermatitis, lichen planus and pityriasis rosea. *Br J Dermatol* 2012;166:1198-205
27. Zalaudek I et al. Dermoscopy in general dermatology. *Dermatology* (2006) 212:7-18
28. Steffen C, Dupree ML. Louis-Frédéric Wickham and the Wickham's striae of lichen planus. *Skinmed* 2004;3:287-9.
29. Lallas A, Zalaudek I, Argenziano G, et al. Dermoscopy in general dermatology. *Dermatol Clin* 2013;31:679-94.
30. Errichetti E, Stinco G. Dermoscopy in General Dermatology: A Practical Overview. *Dermatol Ther (Heidelb)*. 2016;6(4):471-507. DOI: 10.1007/s13555-016-0141-6. PMID: 2761329. PMCID: PMC5120630
31. Lin XF, Chang X, Lin YY, Zhu W. Dermoscopic features of acute widespread lichen planus. *Chin Med J (Engl)*. 2019;132(17):2127-2128. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000388. PMID: 31403971. PMCID: PMC6793790.
32. Mathur M, Acharya P, Karki A, Kc N, Shah J, Jha A. Isolated lichen planus of lip: Diagnosis and treatment monitoring using dermoscopy. *Clin Case Rep*. 2018;7(1):146-148. DOI: 10.1002/ccr3.1933. PMID: 30656029. PMCID: PMC6333123.
33. Lacarrubba F, Ardigò M, Di Stefani A, Verzì AE, Micali G. Dermatoscopy and Reflectance Confocal Microscopy Correlations in Nonmelanocytic Disorders. *Dermatol Clin*. 2018;36(4):487-501. DOI: 10.1016/j.det.2018.05.015. PMID: 30201157.
34. Cook LC, Hanna C, Foulke GT, Seiverling EV. Dermoscopy in the Diagnosis of Inflammatory Dermatoses: Systematic Review Findings Reported for Psoriasis, Lupus, and Lichen Planus. *J Clin Aesthet Dermatol*. 2018;11(4):41-42. PMID: 29657671. PMCID: PMC5891086.
35. Litaïem N, Mansour Y, Jones M, Zeglaoui F. Dermoscopic signs of lichen planus. *BMJ Case Rep*. 2016;2016. pii: bcr2015213923. DOI: 10.1136/bcr-2015-213923. PMID: 26759406. PMCID: PMC4716428.
36. Friedman P, Sabban EC, Marcucci C, Peralta R, Cabo H. Dermoscopic findings in different clinical variants of lichen planus. Is dermoscopy useful? *Dermatol Pract Concept*. 2015;5(4):51-55. DOI: 10.5826/dpc.0504a13. PMID: 26693092. PMCID: PMC4667604.

37. Coelho de Sousa V, Oliveira A. Inflammoscopy in the diagnosis of hypertrophic lichen planus. *J Am Acad Dermatol*.2015;73(5):e171-173. DOI: 10.1016/j.jaad.2015.07.025. PMID: 26475558.
38. Baquero Sánchez E, Lorente-Lavirgen AI, Domínguez Cruz J, Conejo-Mir J. Value of dermoscopy in the diagnosis and prognostic evaluation of linear pigmented lichen planus. *Actas Dermosifiliogr*. 2015;106(4):339-340. DOI: 10.1016/j.ad.2014.09.011. PMID: 25433764.
39. Tan C, Min ZS, Xue Y, Zhu WY. Spectrum of dermoscopic patterns in lichen planus: a case series from China. *J Cutan Med Surg*. 2014;18(1):28-32. DOI: 10.2310/7750.2013.13049. PMID: 4377470
40. Paula Friedman, Emilia Cohen Sabban, Carolina Marcucci et al. Dermoscopic findings in different clinical variants of lichen planus. Is dermoscopy useful? *Dermatol Pract Concept* 2015;5(4):13, doi: 10.5826/dpc.0504a137. Sánchez Dueñas L. Dermatoscopía en enfermedades del pelo y la piel cabelluda. *Dermatol Rev Mex*. 2012;56(3):187-92.
41. Errichetti E. Dermoscopy of Inflammatory Dermatoses (Inflammoscopy): An Up-to-Date Overview. *Dermatol Pract Concept*. 2019;9(3):169-180. DOI:10.5826/dpc.0903a01. PMID: 31384489. PMCID: PMC6659598.
42. Sachdeva S, Sachdeva S, Kapoor P. Wickham striae: etiopathogenesis and clinical significance. *Indian J Dermatol* 2011;56:442-3.
43. Rouai M, Litaïem N, Hammami H, et al. Dermoscopic features of mucosal lichen planus. *Int J Dermatol* 2021;60:1368-72.
44. S. Dash, B. Behera, A. Palit, et al. Dermoscopy of lichen planus under polarized vs nonpolarized mode: a retrospective analysis of 14 patients. *British Association of Dermatologists, Clinical and Experimental Dermatology* January 2021, doi: 10.1111/ced.14565
45. Begona García-García^{1,*} | Pablo Munguía-Calzada¹ | Javier Auban-Pariente, Dermoscopy of lichen planus: Vascular and Wickham striae variations in the skin of colour, *Australasian Journal of Dermatology* (2019) 60, doi: 10.1111/ajd.13052
46. Hanumamaih B et al. Role of Dermoscopy in the Diagnosis of Hypertrophic Lichen Planus and Prurigo Nodularis. *Ind J Dermatol* (2019) 64(5):341-345

47. Madke B, Gutte R, Doshi B, Khopkar U. Hyperkeratotic Palmoplantar Lichen Planus in a child. *Indian J Dermatol.* 2013;58(5):405. DOI: 10.4103/0019-5154.117310. PMID: 24082195. PMCID: PMC3778790.
48. Surabhi S et al. Palmoplantar lesions of lichen planus. *Ind J Dermatol* 2018 (63) 1:57-61
49. Robles-Méndez JC, Rizo-Frías P, Herz-Ruelas ME, Pandya AG, Ocampo Candiani J. Lichen planus pigmentosus and its variants: review and update. *Int J Dermatol.* 2018;57(5):505-514. DOI:10.1111/ijd.13806.
50. Pirmez R, Duque-Estrada B, Donati A, et al. Clinical and dermoscopic features of lichen planus pigmentosus in 37 patients with frontal fibrosing alopecia. *Br J Dermatol.* 2016;175(6):1387-1390. DOI: 10.1111/bjd.14722. PMID: 27233640.
51. Litaïem N, Idoudi S. Frontal Fibrosing Alopecia. In: *StatPearls.Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 10, 2020, p. 1.*
52. Jung J et al. Atypical dermoscopic findings in patients diagnosed with lichen planus by histological examination. *Dermatol Sin* (2017) 35:20-24
53. Amal Chamli, Malek Mrad, Houda Hammami, et al. Dermoscopy of Lichen Planus Pigmentosus and Histopathological Correlation: A Case Series *Dermatol Pract Concept.*2024;14(4):e2024254. DOI: <https://doi.org/10.5826/dpc.1404a254>
54. Szykut-Badaczewska A et al. Dermatoscopy of Cutaneous Lichen Planus –Attempt to Translate Metaphoric Terminology into Descriptive Terminology. *Dermatol Pract Concept* (2023) 13(3): e2023174
55. F. Vazquez-Lo'pez, C. Maldonado-Seral, M. Lo'pez-Escobar, et al. Dermoscopy of pigmented lichen planus lesions. *Clinical and Experimental Dermatology*, January 2003, <https://doi.org/10.1046/j.1365-2230.2003.01302.x>
56. Gungor S et al. Dermoscopic patterns in active and regressive lichen planus and lichen planus variants: a morphological study. *Dermatol Pract Concept* (2015) 5(2):45-53
57. Imbernón-Moya A, Churruca-Grijelmo M, Martínez-Pérez M, Lobato-Berezo A. Dermoscopic Features of Lichen Planus Pigmentosus-Inversus. *Actas Dermosifiliogr.* 2015;106(10):857-859. DOI: 10.1016/j.ad.2015.06.007. PMID: 26341072.

58. Vázquez-López F, Maldonado-Seral C, López-Escobar M, PérezOliva N. Dermoscopy of pigmented lichen planus lesions. Clin and Exp Dermatol. 2003;28:554-5.
59. Chung IY, Wong CC, Rodrigues MA. The importance of dermoscopy in subclinical lichen planus in skin of color. Int J Womens Dermatol. 2021;7(2):205-206. DOI: 10.1016/j.ijwd.2020.12.015. PMID: 33937495. PMCID: PMC8072490.
60. Jurakic Toncic R, Lončarić D, Caccavale S, Garces J, Radoš J. Annular Atrophic Lichen Planus - A Case Report. Dermatol Pract Concept. 2021;e2021123. DOI: 10.5826/dpc.1104a123. PMID: 35024232. PMCID: PMC8648430.
61. Morales-Callaghan A, Martínez G, Aragonese H, Miranda-Romero A. Annular atrophic lichen planus. J Am Acad Dermatol. 2005;52(5): 906-908. DOI: 10.1016/j.jaad.2004.12.027. PMID: 15858488.
62. Iga N, Sakurai K, Murata T, et al. Wickham's striae presented with whitish ring-form on annular lichen planus. J Dermatol. 2013;40(12):1060-1061. DOI: 10.1111/1346-8138.12345. PMID: 24330176.
63. Awatef Kelati, Asmae Rasso, , Soumia Chiheb, Dermoscopy of Actinic Lichen Planus in Skin of Color. Dermatol Pract Concept. 2024;14(2):e2024101, DOI: <https://doi.org/10.5826/dpc.1402a101>
64. Errichetti E. Dermoscopy of Inflammatory Dermatoses (Inflammoscopy): An Up-toDate Overview. Dermatol Pract Concept (2019) 9(3):169-180.
65. Cetinarslan T et al. Dermatoscopic Findings in Palmoplantar Dermatoses (2021) Dermatoscopy Edited by Pawel Pietklewicz IntechOpen
66. Chaduvula J et al. A Clinico-epidemiological Study of Hyperkeratotic Palmoplantar Lesions and Its Correlation with Dermoscopy and Histopathology in a Tertiary Care Center. Cureus (2023) 15(3): e36561
67. Madke B, Doshi B, Wankhede P, Nayak C. Palmar lichen planus mimicking tinea nigra. Indian J Dermatol. 2013;58(5):407. DOI: 10.4103/0019-5154.117339. PMID: 24082209. PMCID: PMC3778804.
68. Makhecha M et al. A novel dermoscopic finding-lichen planus pemphigoides. Int J Dermatol (2022) 61: e320-e362.
69. 132. Narkhede N et al. Evaluation of Dermoscopic Patterns of Vesiculobullous Disorders. Ind J Dermatol (2021) 66(4):445.

70. Batra P et al. Linear lichen planus. *Dermatol Online J* (2008) 14(10):16.
71. Lehman JS et al. Lichen planus. *Int J Dermatol* (2009) 48(7) :682-94.
72. Pai K et al. Zosteriform lichen planus: case report of a rare variant of lichen planus. *Our Dermatol Online* (2013) 4(2):183
73. Hartl C et al. Unilateral linear lichen planus with mucous membrane involvement.
Acta Derm Venereol (1999) 79(2):145-6
74. Sciallis GF et al. Progressive linear lichen planus and metastatic carcinoma. *Br J Dermatol* (2005) 152(2);399-401
75. Méndes R et al. Lichen planus pigmentosus and its variants. *Int J Dermatol* (2017) 57(5):505-514.
76. 135. Rather S et al. Dermoscopy of Oral Mucosal Lesions Experience from a Tertiary Care Center in North India and Review of Literature (2022) *Ind Dermatol Online J* 13(3):p346-360
77. Roual M et al. Dermoscopic features of mucosal lichen planus. *Int J Dermatol* (2021) 60(11):1368-1372.
78. Neema S et al. Dermoscopy of Lip Lichen Planus – A Descriptive Study. *Dermatol Pract Concept* (2020) 10(4):2020076.
79. Job AM et al. Lichen planus hypertrophicus of the vulva- a rare entity. *Int J STD AIDS* (2017) 28:1048-50.
80. Moyal Barracco M et al. Diagnosis and therapy of anogenital lichen planus. *Dermatol Ther* (2004) 17:38-46.
81. Pelisse M et al. A new vulvovaginogingival syndrome. Plurimucous erosive lichen planus. *Ann Dermatol Venereol* (1982) 109 :797-8
82. Petruzzi M et al. Peno-gingival lichen planus. *J Periodontol* (2005) 76 : 2293-8
83. Le Cleach L et al. Lichen planus. *N Engl J Med*. (2012) 366 :723-32.
doi:10.1056/NEJMc1103641.
84. Borghi A et al. Dermoscopy of Inflammatory Genital Diseases: Practical Insights. *Dermatol Clin* (2018) 36:451-46169
85. Borghi A et al. Preliminary study on dermoscopic features of vulvar lichen planus: new insights for diagnosis. *J Eur Acad Dermat Venereol* (2016) 30:1063-1065

86. Lacarrubba F et al. Dermoscopy of genital diseases: a review. J Eur Acad Dermat Venereol (2020) 34(10):2198-2207
87. Maatouk I et al. Dermoscopy for venereologists: an update on patterns of tumors, inflammatory and infectious diseases of the genitalia, and tips for differential diagnosis. Intern J Dermatol (2021) 60:1211 -1218
88. Chakiri R. Penile lichen planus recognized by dermoscopy: a case report. PanAfric Med J (2020) 3(141).
89. Waskiel A et al. Trichoscopy in lichen planopilaris: an update. Dermatol Rev/Przegl Dermatol (2018) 105:63-75
90. Saber M et al. Double ring sign as a specific dermoscopic feature of lichen planopilaris: Toward a deeper understanding of disease. J Cosmet Dermatol (2023) 00:1-4.
91. R. Pirmez, B. Duque-Estrada, A. Donati, Clinical and dermoscopic features of lichen planus pigmentosus in 37 patients with frontal fibrosing alopecia, British Journal of Dermatology (2016), DOI: 10.1111/bjd.14722.
92. Nakamura R et al. Dermatoscopy of nail lichen planus. Int J Dermatol (2013) 52(6):684-7.
93. Goettmann S, Zaraa I, Moulonguet I. Nail lichen planus: epidemiological, clinical, pathological, therapeutic and prognosis study of 67 cases. J Euro Acad Dermatol Venereol. 2012;26:1304-9.
94. Nakamura R, Broce AA, Palencia D, Ortiz NI, Leverone A. Dermatoscopy of nail lichen planus. Int J Dermatol. 2013;52:684-7.
95. Laura Fagotto, Laura Gnesotto, Colombina Vincezi, et al. Wickham striae on skin appendages: a helpful dermoscopic feature. Dermatol Reports. 2023 Jun 6;15(3):9698. doi: 10.4081
96. Şu le Güngör¹, İlteriş O. Topal¹, Emek K. Göncü, Dermoscopic patterns in active and regressive lichen planus and lichen planus variants:a morphological study. Dermatol Pract Concept 2015;5(2):6. doi: 10.5826/dpc.0502a06.
97. Tosti A, Duque-Estrada B. Dermoscopy in hair disorders. J Egypt Women Dermatol Soc. 2010;7:1-4.
98. Rudnicka L, Olszewska M, Rakowska A, Slowinska M. Trichoscopy update 2011. J Dermatol 2011;5(4):82-8.

